Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (nCov) – Covid - 19

Município de Pitangueiras

Rede Municipal de Saúde

Santa Casa de Pitangueiras

Convênios: UNIMED / SERMED / SÃO FRANCISCO

Pitangueiras 22 /04/2020

Revisão

Este Plano será revisado, conforme novas orientações sejam fornecidas por órgãos Estaduais e Federais:

Revisado: 18/05/2020
Revisado: 20/05/2020
Revisado: 09/06/2020
Revisado: 15/06/2020
Revisado: 24/06/2020
Revisado: **22/07/2020**
Revisado:
Revisado:
Revisado:

Prefeitura Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde

Prefeito Municipal de Pitangueiras
Marcos Aurélio Soriano

Secretária Municipal de Saúde
Ana Celeste Crotti Peixoto

Objetivo:
Este plano tem como objetivo nortear as ações dos Serviços de Saúde municipais de Pitangueiras e está baseado em recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Introdução

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório nacional da Organização Mundial de Saúde (OMS), na China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, Província de Hubei.

Em 09 de janeiro de 2020, houve a divulgação da detecção de um novo coronavírus (2019-nCoV) em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Desde então, casos da doença foram registrados na China e em outros países.

Em 30 de janeiro de2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo adequado dos casos, investigação, monitoramento dos contatos e notificação oportuna.

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderada de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre**.** Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. O que é mais comum acontecer em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos.

O 2019-nCoV é um novo coronavírus que ainda não havia sido identificado em humanos. A suscetibilidade é geral e o espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave.

A transmissão dos coronavírus é por via respiratória e por contato com secreções contaminadas, como: Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 14 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. O quadro clínico inicial da doença é a síndrome gripal.

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.

Também o individuo pode ser assintomático.

O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF), esta coleta pode ser realizada até o 7° dia do início dos sintomas (do 3° dia ao 7º dia).

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas.

Em abril de 2020 o municipio instituiu uma Comissão de enfrentamento ao COVID- 19 2019-nCoV (ver anexo).

Para dispor sobre medidas de prevenção ao contágio, enfrentamento e contingenciamento da epidemia da doença infecciosa viral respiratória, conforme situação de emergência em saúde pública foi criado na Secretária Municipal de Saúde uma **Comissão de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (COVID-19)**

Objetivos da Comissão:

- Acompanhar a evolução do quadro epidemiológico e, principalmente, adotar e fixar medidas para a prevenção, controle do contágio e o tratamento de pessoas que apresentam sintomas ou que venham apresentar casos positivos para a doença.
- Operacionalizar as atividades e os processos de repasse de informações, discutir fluxo de atendimento e avaliar ações realizadas, promover Educação em serviço.

Comissão de enfrentamento ao novo coronavirus Covid 19

- Secretário Municipal de Saúde: Ana Celeste Crotti Peixoto
- Médico Infectologista: Dra Maria Rita Margarido Chaparim
- Coordenador VE: Mariela Lucia Cerissa
- Diretor VISA: Tiago Paes
- Diretor Rede Atenção a Saúde: Dirce Maria Silveira Marques
- Diretor AB e Especializada: Eliese Buzati
- Chefe de Gabinete: Andreia Mantovani da Fonseca

Também foi criado um grupo de WhatsApp para informações e discussões, além de utilização dos e-mails dos serviços de saúde para o envio de materiais pertinentes.

Plano de Contingência Municipal, elaborado em consonância com o Plano Estadual
Contem dois eixos:

- Eixo I - Vigilância em Saúde
- Eixo II - Assistência à Saúde

Eixo I - Vigilância em Saúde

a) **Vigilância Epidemiológica**
Doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV – CID 10: B34.2 - Infecção por coronavírus de localização não especificada

Objetivo Geral

Orientar o Sistema de Vigilância em Saúde e a Rede de Unidades de Saúde do município para atuação na identificação, notificação e investigação de casos suspeitos de

Doença Respiratória Aguda pelo 2019 - nCoV, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos de transmissão.

Objetivos Específicos

- Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde, contatos próximos e população em geral;
- Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;
- Disseminar informações epidemiológicas;

DEFINIÇÃO DE CASOS

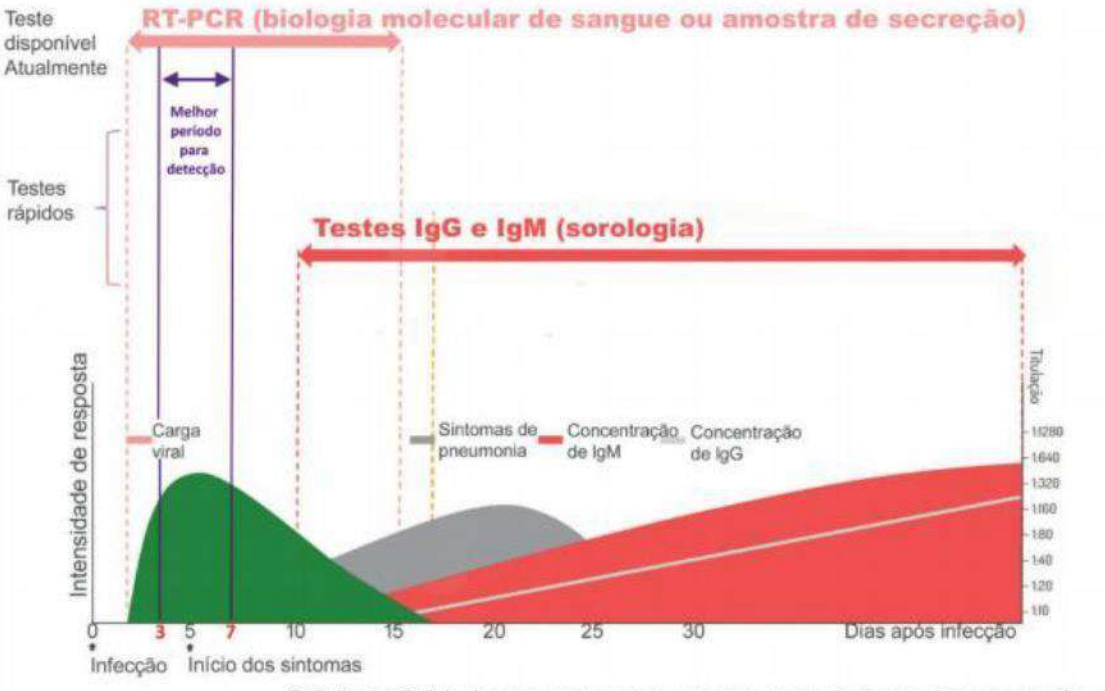
- **CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)**

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus covid-19 avaliar sinais e sintomas.

- **CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)**
  Teste molecular: PCR em tempo real (RT-PCR)
  Testes imunológicos: teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos

1- Com realização de Teste laboratorial:

Etapas para a realização do RT-PCR em tempo real e recomendações técnicas



Referência: Cellular immune responses to severe acute respiratory syndrome coronavirus infection insenescent BALB/c Mice:CD4+T cells are important in control of SARD-CoV infection.

Interpretação dos testes molecular e sorológico para diagnóstico laboratorial de COVID-19.

TIPOS DE TESTES			INTERPRETAÇÃO
Molecular	Sorologia		
rRT-PCR	IgM	IgG	
Positivo	Negativo	Negativo	Paciente pode estar na janela do período de infecção
Positivo	Positivo	Negativo	Paciente pode estar na fase inicial da infecção
Positivo	Positivo	Positivo	Paciente está na fase ativa da infecção
Positivo	Negativo	Positivo	O paciente pode estar no estágio tardio ou recorrente da infecção
Negativo	Positivo	Negativo	• O paciente pode estar no estágio inicial da infecção. O resultado da PCR pode ser falso-negativo. • O teste de anticorpos pode ser falso positivo
Negativo	Negativo	Positivo	• O paciente pode ter tido uma infecção passada e se recuperou. • O teste de anticorpos pode ser falso positivo
Negativo	Positivo	Positivo	• O paciente pode estar no estágio de recuperação de uma infecção ou o resultado da PCR pode ser falso-negativo • O teste de anticorpos também pode ser falso positivo

(**Fonte: https://portalarquivos.saude.gov.br/ images/ pdf /** 2020/April/27/2020 -04-27-18-05h -BEE14-Boletim-doCOE.pdf).

Técnicas:

I-Teste molecular: PCR em tempo real (RT-PCR) pelo protocolo Charité.

O diagnóstico laboratorial para a identificação do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real ou testes imunológicos.

É uma técnica de laboratório na qual o material genético inicial do vírus (RNA) é transcrito no reverso em seu complemento de DNA por enzima transcriptase reversa.

Vários fatores podem levar a um resultado negativo em um indivíduo infectado através do RT-PCR em tempo real, incluindo:

Má qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente.

A amostra foi coletada em uma fase muito precoce (menos de 3 dias) ou tardia (mais de 7 dias) da infecção;

A amostra não foi manuseada e enviada adequadamente;

Razões técnicas inerentes ao teste.

Portanto, a interpretação dos resultados deve ser realizada levando em consideração o quadro clínico, as exposições e o exame realizado.

II-Testes imunológicos: teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos

Visam detectar anticorpos específicos, os métodos sorológicos são desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG e IgM ou detecção de antígenos específicos do vírus, alguns por ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e imunocromatográficos (teste rápido), imunofluorescência (IF) e outros por quimioluminescência (CLIA). A sensibilidade e especificidade dos testes variam de acordo com o fabricante.

Os testes utilizados deverão ter aprovação da ANVISA.

Realização de Teste Rápido:
Utilizam amostras de sangue capilar ou venoso
O profissional deverá conhecer o manual de orientação do MS e do Fabricante do teste
O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico de COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

Observação:
Resultado indeterminado: se o profissional que realizou o teste rápido não conseguir interpretar o exame, devido dúvida na leitura (trata-se de exame subjetivo sujeito a diferentes interpretações), caracteriza-se resultado indeterminado.
Nestes casos, o teste rápido deve ser repetido. Se o primeiro teste foi realizado antes do décimo dia de sintomas, deverá ser repetido após o décimo dia. Se o primeiro teste foi realizado após o décimo dia de sintomas, deverá ser repetido após 2 dias.
Exames realizados na Santa Casa de Pitangueiras com resultado indeterminado deverão ser encaminhados para a unidade gripal com devida ficha preenchida com justificativa e resultado do exame anterior, para que seja repetido e interpretado por profissional diferente do teste inicial.
Ressalta-se que o teste rápido pode ser feito em qualquer período após o décimo dia de sintomas, pois os anticorpos do tipo IgG irão ficar positivos por semanas ou meses após a doença (ainda não se sabe o período, porém baseado na experiência dos outros coronavírus, pode permanecer por cerca de 3 a 6 meses).

Orientações quanto a afastamento de pacientes suspeito de COVID-19
Pacientes com sintomas compatíveis com síndrome gripal, que passaram por consulta médica e foram afastados por 14 dias, devem permanecer em afastamento durante todo o período (completar os 14 dias),
Quando:

- Não realizarem exame diagnóstico (não coletaram PCR ou Sorologia).
- Tem resultado de teste rápido, positivo ou negativo (o teste rápido não tem confiabilidade de 100% e o resultado negativo, frente a sintomas compatíveis, não exclui a doença)
- Realizam PCR (swab) com resultado positivo

O retorno as atividades de trabalho, necessitam dos 14 dias, e que o paciente esteja sem os sintomas gripais .
Em exame PCR (swab) com resultado negativo, o individuo pode retornar ao trabalho antes do período de 14 dias, se o exame foi coletado no período adequado (do 3º ao 7º dia de sintomas) e o paciente esteja com resolução completa do quadro gripal inicial (assintomático).

Como notificar os casos suspeitos e os resultados dos testes rápidos :

Notificar em formulário apropriado e encaminhar para a Vigilância Municipal que utiliza os Sistemas: Síndrome Gripal (SG) eSUS-VE, SRAG e óbitos: SIVEP Gripe, Surto de SG: SINAN

É obrigatório registrar os dados de todas as pessoas submetidas ao teste rápido sorológico. Informando o resultado.

Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso com o resultado positivo ou com resultado negativo. Essas informações são essenciais para monitoramento da epidemia no Brasil.

Paciente assintomático com teste sorológico reagente: É preciso avaliar qual classe de Anticorpo. Se for IgM e IgG reagente ou apenas IgG reagente considerar como caso confirmado. Se for apenas IgM reagente e IgG não reagente refazer teste após 10 dias de inicio de sintomas . Os casos confirmados assintomáticos deverão ser notificados no e-SUS VE

Exames disponíveis no Município:

Disponibilizados para utilização na Unidade de Atendimento Gripal, Pronto Atendimento de Ibitiúva e Pronto Atendimento da Santa Casa de Pitangueiras.

Exame RT-PCR para Síndrome Gripal RT-PCR SWAB ORO-FARINGE

Quando realizar: do 3º ao 7º dia de sintomas

Grupo para Testagem: Ver anexo 13 (atualizado em 22/07/2020)

Teste Rápido COVID-19:

Quando realizar: A partir do 10º dia de sintomas. (preferencialmente no 14ª dia)

Grupo para Testagem: Ver anexo 13 (atualizado em 22/07/2020)

Formulários para o Laudo e o Controle dos Testes realizados:

1- Modelo de Laudo: RESULTADO DO EXAME REALIZADO

TESTE COVID 19 - KIT 2019-nCoV IgG/IgM
Teste Rápido em Cassete
NOME PACIENTE:_____
RESULTADO EXAME
DATA:____/_____2020
( ) POSITIVO / REAGENTE IgM/ IgG POSITIVO
( ) NEGATIVO / NÃO REAGENTE
Valor de referencia: negativo/não reagente Método: Imunocromatografia
Limitações do teste:
1. O teste rápido em cassete 2019-nCoV IgG/IgM (Sangue Total/ Soro/Plasma) é apenas para uso em diagnóstico in vitro. Este teste deve ser usado para a detecção de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV em amostras de sangue total, soro ou plasma. Nem o valor quantitativo nem a taxa de aumento da concentração de anticorpos IgG ou IgM para 2019-nCoV podem ser determinados por este teste qualitativo.
2. O teste rápido em cassete 2019-nCoV IgG/IgM (Sangue Total/ Soro/Plasma) indicará apenas a presença de anticorpos IgG e IgM para 2019- nCoV na amostra e não deve ser usada como o único critério para o diagnóstico de infecções por 2019-nCoV.
3. Como em todos os testes de diagnóstico, todos os resultados devem ser considerados com outras informações clínicas disponíveis para o médico.
4. Se o resultado do teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, sugerimos testes adicionais de acompanhamento usando outros métodos clínicos. Um resultado negativo a qualquer momento não exclui a possibilidade de infecção por 2019-nCoV.
5. O Teste mostrará resultados negativos nas seguintes condições: O título dos novos anticorpos para o coronavírus na amostra é inferior ao limite mínimo de detecção do teste ou o novo anticorpo para o coronavírus não apareceu no momento da colheita da amostra (Fase assintomática).

2-Registro na Unidade Aplicadora do Teste

Identificação do Teste:

Data	Nome do paciente	Telefone	Resultado P: Positivo N: Negativo	Unidade de saúde	Rubrica do Profissional

2-CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

OBSERVAÇÃO:

- FEBRE: Considera-se febre aquela acima de 37,8°. Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

Notificação e Registro

A Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV é uma potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata. Os casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV devem ser notificados de forma imediata pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.

As informações devem ser inseridas no formulário especifico utilizando CID10: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada.

O fluxo de informação entre os diversos níveis do sistema de vigilância em saúde é ágil de modo a contemplar todos simultaneamente, ou seja, a informação de um caso é passada para todos os níveis ao mesmo tempo: nível central estadual, nível regional estadual e nível municipal.

A informação de um caso suspeito ou de vários casos, informações da investigação, resultados laboratoriais e conclusão do caso ou surto seguem o mesmo fluxo.

Os casos que atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG1) são notificados concomitantemente no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).

DIAGNÓSTICO DO COVID-19

Teste molecular: PCR em tempo real (RT-PCR)

O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou coleta de secreções da boca e nariz).

Nossas referencias laboratoriais são o Laboratório Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o Laboratório Pardine (Ver Anexo 2).

Exame (amostra swab nasofaringe) de paciente que se enquadra em definição de caso.

Colher amostra swab nasofaringe → Manter amostra sobre refrigeração.

→ Preencher Ficha com todos os dados e Notificar para a VE Municipal

→

Vigilância Epidemiológica De 2ª a 6ª feira

- Buscar a amostra coletada no Serviço de Saúde, digitar a solicitação do exame no GAL (A. Lutz) e conferir formulário (Laboratório Pardine) e enviar o material e formulários para o Laboratório . Observação: O pedido medico deverá ser encaminhado junto.

- O envio do material para o Laboratório Pardine é via Laboratório PACCA Sertãozinho_
- Comunicar o novo caso aos setores competentes
- Acompanhar a evolução do estado clínico do paciente e seus comunicantes. Oferecer orientações e documentar ações realizadas. Acompanhar a emissão do resultado de exame e informar o paciente, o Serviço notificante e órgãos competentes.
- Materiais coletados de Finais de Semana e feriados devem ser refrigerados, para envio até 72 h. O Laboratório PACCA Sertãozinho recebe a amostra e envia para Laboratório Pardine 24 h.
- A coleta do material deve obedecer rigorosamente o intervalo de 3ª dia de sintomas até 7º dia de sintomas do paciente. Tanto a coleta precoce como a coleta tardia interferem no resultado do exame.

Medidas de Prevenção e Controle em Serviços de Saúde a serem adotadas na Assistência à Saúde as medidas de prevenção da transmissão viral nos serviços de saúde incluem:

1. Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos adotados na prestação de serviços de assistência à saúde aos pacientes suspeitos de infeção pelo 2019-nCoV;
2. Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, com fornecimento de máscaras cirúrgicas ao paciente sintomático ou identificado como suspeito, desde o momento que chegam na unidade;
3. Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e garantia de suprimentos de equipamentos de proteção individual (EPI) aos pacientes e profissionais envolvidos no atendimento;
4. Isolamento hospitalar em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado, com a entrada sinalizada alertando isolamento respiratório para gotículas e contato;
5. Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização das mãos e a etiqueta respiratória;
6. Garantir a ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene ambiental adequada.

Medidas de Prevenção para a Comunidade

No momento não há tratamento e vacina específicos para a infecção humana pelo 2019-nCoV.
As principais medidas de prevenção são:

1. Higiene de mãos com água e sabonete ou produto alcoólico;
2. Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com lenço descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos com água e sabonete ou produto alcoólico;
3. Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios.
4. A OMS recomenda que indivíduos assintomáticos (ou seja, que não têm sintomas respiratórios) na comunidade usem máscaras de tecido.
5. Pessoas sintomaticas e seus comunicantes devem seguir rigorosamente as orientações e prescrições medicas.

Eixo 2 – Assistência à Saúde
Rede de Assistência

Medidas Gerais:

- Seguir normas e rotinas preconizados na prestação de serviços de atenção à saúde de

pacientes suspeitos de infecção pelo nCoV.

- Organizar o fluxo de atendimento e encaminhar pacientes sintomaticos respiratorios para atendimento na Unidade de Atendimento Sintomatico Respiratorio .
- Fornecer máscara cirúrgica ao paciente sintomático e ou identificado como suspeito Os pacientes devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados até sua chegada ao local definido para atendimento
- Afixar cartazes ou outras formas de comunicação com orientações aos pacientes sobre etiqueta respiratória.

Higienização das mãos:

- Higienização frequente das mãos, principalmente antes e depois da assistência ao paciente e após a retirada de EPI.
- As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e sabonete líquido ou preparação alcoólica.
- Os profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser devidamente instruídos e monitorados quanto à importância da higienização das mãos.

Uso de EPI

- **Recepção:** Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar e protetor facial.
- **Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais em atendimento para pacientes assintomáticos:** Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar e protetor facial.
- **ACS e ACE e outros profissionais nas visitas**: Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar e protetor facial.
- **Pré e Pós-consulta para pacientes assintomáticos**: Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar e protetor facial.
- **Profissionais que realizam Triagem e procedimentos sem risco biológico:** Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar e protetor facial.
- **Profissionais que realizam procedimentos com risco biológico**: Mascara cirúrgica e óculos ou mascara N95 ou similar , protetor facial , avental, gorro e luvas .
- **Profissionais que realizam procedimentos que gerem aerossóis**: Mascara N95 ou similar e, óculos ou protetor facial, avental, gorro e luvas.
- **Pacientes sintomáticos respiratórios:** Mascaras Cirúrgicas

Luvas

O uso de luvas de procedimentos não cirúrgicos é obrigatório para qualquer contato com paciente suspeito ou confirmado de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do nCoV para o profissional, assim como de paciente para paciente por meio das mãos do profissional.

Quando o procedimento a ser realizado exigir técnica asséptica deve ser utilizado luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). Devem ser descartadas imediatamente após o uso.

Protetor ocular ou protetor de face

Os óculos de proteção (ou protetor de face) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.

Os óculos de proteção devem ser exclusivos para cada profissional responsável pela assistência, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão/detergente e

desinfecção.

Sugere-se para a desinfecção álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante.

Óculos convencionais (de grau) não devem ser usados como protetor ocular, uma vez que não protegem a mucosa ocular de respingos. Os profissionais de saúde que usam óculos de grau devem usar sobre estes os óculos de proteção ou protetor de face.

Capote/avental (de mangas longas)

O capote ou avental deve ser utilizado durante toda a manipulação do paciente suspeito ou confirmado, ou manipulação de qualquer material ou equipamento utilizado pelo paciente (como cateteres, sondas, circuito, equipamento ventilatório e outros) além de contato com superfícies próximas ao leito, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional.

O capote ou avental sujo deve ser removido após a realização do procedimento. Utilizar preferencialmente avental descartável (de uso único). Em caso de avental de tecido, este deve ser reprocessado em lavanderia hospitalar.

Mascaras

Uso adequado de máscaras

O uso e descarte apropriados das máscaras são essenciais para garantir a eficácia e evitar o aumento no risco de transmissão associado ao uso e descarte incorretos de máscaras.

Para o uso correto de máscaras:

Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar as lacunas entre a face e a mascara;

Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;

Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas remover por trás);

Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, higienizar as mãos usando produto alcoólico ou água e sabão se as mãos estiverem visivelmente sujas;

Descartar imediatamente após a remoção

Substituir a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que ficar úmida;

Não reutilizar máscaras descartáveis;

Descartar máscaras descartáveis após cada uso;

Máscaras de pano (por exemplo, algodão ou gaze) não são recomendadas sob qualquer circunstância.

Higienização de Teclados

Os teclados e mouses deverão ser higienizados diariamente no mínimo 3 x ao dia, com Alcool 70% .

Transporte de pacientes:

Os profissionais que manipularem o caso suspeito ou confirmado durante a preparação para o transporte devem adotar as medidas de precaução para gotículas e contato:

- O paciente deve usar máscara cirúrgica durante todo o transporte;
- O uso de luvas ou avental para os profissionais envolvidos no transporte deve ser adotado se forem manipular o paciente;
- A equipe de saúde que vai manipular o paciente durante o transporte deve adotar medidas de precaução respiratória e de contato

- Adequar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;
- Intensificar a higienização das mãos;
- O veículo utilizado no transporte deverá ser submetido ao processo de limpeza e desinfecção de todas as suas superfícies, com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, antes do próximo uso.

Processamento de Produtos para a Saúde

Produtos para a saúde ou artigos utilizados na assistência de pacientes com infecção por nCoV, devem ser processados de acordo com as características e finalidades de uso, orientação dos fabricantes e métodos escolhidos.

Equipamentos, produtos para a saúde ou artigos utilizados em qualquer paciente devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas, ou a transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambientes. Desse modo, é importante frisar a necessidade da adoção das medidas de precaução na manipulação dos mesmos.

Limpeza e Desinfecção

A orientação sobre a limpeza e a desinfecção de superfícies em contato com pacientes com suspeita ou infecção por nCoV é a mesma utilizada para outros tipos de doença respiratória.

A desinfecção de superfícies das unidades de isolamento deve ser realizada após a sua limpeza. Os desinfetantes com potencial para a desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois e o quaternário de amônio. Os artigos, produtos para saúde ou equipamentos devem ser de uso exclusivo dos pacientes suspeitos ou confirmados de nCoV, devendo ser realizada desinfecção com álcool 70% para o uso compartilhado, evitando a transmissão cruzada do vírus.

Processamento de Artigos Utilizados pelo Paciente

Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na atenção ao paciente.

Estabelecer fluxos e rotinas de transporte de equipamentos, produtos para a saúde ou artigos utilizados na assistência.

Utilizar preferencialmente artigos descartáveis.

Esterilizar ou desinfetar artigos reprocessáveis, conforme a rotina já estabelecida pela Central de Material Esterilizado (CME) e pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Para os itens compartilhados por demais pacientes (ex.: esfigmomanômetro, oxímetro de pulso, dentre outros), realizar a limpeza e a desinfecção, conforme a rotina já estabelecida.

Descarte de Resíduos:

O SARS-CoV-2 é enquadrado como agente biológico classe 3 http: // bvsms .saude .gov.br/bvs/publicações/classificacao_risco_agentes_biologicos_3e d.pdf. Portanto, os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018 (disponível em http: // portal. anvisa .gov .br/ documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081db 331-4626-8448-c9aa426ec410). Estes devem ser acondicionados em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com

cantos arredondados e resistente ao tombamento.

Medidas de prevenção populacional:

- Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
- Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e
- Manter os ambientes bem ventilados.

Etiqueta Respiratória:

- Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e nariz com um lenço de papel e descarte-o imediatamente no lixo.
- Caso não tenha lenço ou papel, utilizar o antebraço para tossir e ou espirrar. Não usar as mãos para cobrir a boca, pois são importantes meios de contaminação.
- Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar, use água e sabonete ou álcool gel.

Cuidados em Casa

Pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por SARS-CoV-2 com sinais e sintomas que permitam assistência domiciliar devem seguir as seguintes recomendações:

- Manter o paciente em quarto individual bem ventilado. Caso não seja possível manter em quarto privativo, manter a distância de pelo menos 1 metro da pessoa doente.
- Limitar o número de cuidadores e não receber visitas.
- Limitar a circulação do paciente e verificar se ambientes compartilhados (ex: cozinha, banheiro) são bem ventilados (manter as janelas abertas).
- O cuidador deve usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiver na mesma sala e durante a manipulação da pessoa doente. As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada.
- Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou produto alcoólico após a remoção da máscara.
- Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar, preferencialmente, toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel descartáveis não estejam disponiveis, usar toalhas de pano e trocar quando ficarem molhadas.
- Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo flexionado, seguido de higiene das mãos.
- Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após o uso.
- Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos antes e depois da remoção das luvas.

- Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados com o paciente devem ser colocadas em lixeira com saco de lixo no quarto da pessoa doente antes do descarte com outros resíduos domésticos.
- Evitar o compartilhamento de talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas de cama.
- Talheres e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente comum após o uso e podem ser reutilizados.
- Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paceinte diariamente com desinfetante doméstico comum.
- Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com desinfetante doméstico comum.
- Roupas limpas e sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de mão do paciente devem ser lavadas com água e sabão comum. Evitar agitar a roupa suja.
- Usar luvas descartáveis e roupas de proteção (por exemplo, aventais de plástico) ao limpar ou superfícies, roupas ou superfícies com fluidos corporais. Retirar o avental antes da remoção das luvas e realizar higiene das mãos imediatamente após.
- Os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas.

Indivíduos que podem ter sido expostos a casos suspeitos de infecção por nCoV (incluindo cuidadores e trabalhadores de saúde) devem ser aconselhados a monitorar sua saúde por 14 dias, a partir do último dia do possível contato, e procurar atendimento médico imediato se desenvolver quaisquer sintomas, particularmente, febre, tosse ou falta de ar.

Contatos sintomáticos devem procurar um serviço de saúde .

Fluxo de atendimento no Município

1) UNIDADE DE ATENDIMENTO GRIPAL:

Criada a parir de 22/04/2020 tendo por objetivo aumentar a cobertura de atendimento e agilizar a identificação de casos suspeitos de coronavírus (Covide -19).

Localizada à Rua Minas Gerais nº 253 Centro (ao lado do Correio)

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira das 7:00 as 19:00 (exceto feriados)

Equipe: Contrato emergencial

- 2 Médicos 12 hs cada, em dias alternados
- 2 Enfermeiro 6 hs/ dia , cada
- Técnico de Enfermagem: 8 hs/ dia cada

Esta unidade conta com triagem do paciente por profissional técnico de enfermagem ou enfermeiro, o qual aplica questionário padrão pré-formulado, com questões de verificação se o paciente apresenta sintomas como: febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, falta de

ar. As perguntas são objetivas a fim de reduzir o tempo deste primeiro contato e evitar exposição prolongada.

A triagem também conta com aferição de sinais vitais na ficha padrão, com dados de antropometria, saturação de oxigênio por oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, frequência respiratória e frequência cardíaca. De acordo com a gravidade do caso, é dada prioridade de atendimento médico ao paciente (casos com alteração de sinais vitais ou queixa de falta de ar terão prioridade). É fornecida máscara cirúrgica ao sintomático, caso já não esteja fazendo uso, desde a triagem.

Após triagem o paciente é encaminhado à consulta médica, na qual é realizada anamnese e exame clínico, também contando com formulário padrão, que também inclui campo para marcação de fatores de risco, como idade, comorbidades e gestação. Após avaliação médica é dada conduta, a qual pode ser alta com fornecimento de atestado para afastamento por período determinado pelo profissional de saúde, medicação no local (realizada por enfermeiros ou técnicos) com observação ou encaminhamento ao hospital de referência.

O encaminhamento ocorre de acordo com a avaliação médica, em casos que acredite haver gravidade e necessidade de possível internação hospitalar. O transporte deve ser por meio de ambulância até a Santa Casa de Pitangueiras. O caso é previamente discutido e passado ao profissional médico da Santa Casa e de lá encaminhados para nível secundário ou terciário conforme definido e pactuado pelo município e pela Secretária de Estado da Saúde.

Para prescrição de medicamentos domiciliares específicos é seguido protocolo do Ministério da Saúde (por exemplo, prescrição de Oseltamivir conforme definição de Síndrome Gripal com fatores de risco). Deverá constar na receita medica o risco do paciente. E a unidade deve fazer um controle das prescrições, para encaminhamento a Farmácia Municipal.

Os exames de PCR e os testes rápidos são realizados conforme protocolo ministerial e municipal.

Todos os profissionais fazem uso de EPI com paramentação completa conforme já estabelecido em protocolo municipal e de acordo com as normas da ANVISA. Também são orientados quanto ao uso e desparamentação corretos, para evitar contaminação.

O afastamento dos sintomáticos respiratórios e seus contactantes são oferecidos nesta Unidade, que deverá preencher a notificação, e os formulários conforme instrução da Vigilância Epidemiológica Municipal e encaminhar as mesmas para a Vigilância Epidemiológica Municipal que fará acompanhamento por telefone dos casos.

O afastamento de funcionários da saúde segue protocolo instituído , sendo afastados funcionários sintomáticos e contactantes domiciliares de sintomáticos. O retorno às atividades acontece conforme protocolo vigente.

Também é o acompanhamento por aplicativo para casos suspeitos e confirmados da COVID 19. Através deste o pacientes poderão também se auto-monitorar, e evitar ida sem necessidade à Unidade de saúde.

Para o acesso utilizar o aplicativo Coronavírus SP:

Google Store
https://playgoogle.com/store/apps/details?id=brgov.sp.prodesp.coronavirus.sp
AppleStore
https://apps.apple.com/br/app/coronavirus-sp/id1504141813

A limpeza do local de triagem e atendimento ocorre de forma constante por profissional da limpeza, orientado quanto ao uso de EPI e procedimentos para correta desinfecção e limpeza de superfícies.

Protocolo de Atendimento Unidade de Atendimento Gripal de Pitangueiras

- Atendimento de pessoas de 2 anos ou mais.
- Crianças de 0 a 2 anos atender nas Unidades de Saúde.

Exames Laboratoriais
Podem ser solicitados exames como:

- Hemograma completo: principalmente em caso de dúvida de infecção bacteriana associada, para avaliar leucocitose e desvio a esquerda. Leucopenia é sugestiva de infecção viral (no caso de COVID-19 pode sugerir maior gravidade).
- Gasometria arterial: se houver dúvida na saturação de O2 em oximetria de pulso pode ser solicitada para auxílio na estratificação de gravidade.(só realizada no município no laboratório PACCA)
- TGO e TGP: podem ajudar no diagnóstico em caso de dúvida, pois podem estar aumentados na infecção viral.
- Creatinina e Ureia, Eletrólitos: principalmente se há suspeita de comprometimento sistêmico, em casos mais graves ou pacientes com comorbidades que possam afetar a função renal.

* Em casos de febre e mialgia sem sintomas respiratórios lembrar-se do diagnóstico diferencial com dengue – hemograma com leucopenia ou leucocitose, plaquetopenia, hemoconcentração (aumento de HT), pode haver aumento de TGO e TGP.

Exames para detecção do Vírus ou IgM e IgG
Exame RT-PCR para Síndrome Gripal RT-PCR SWAB ORO-FARINGE
Teste rápido COVID-19

Exames de Imagem
Radiografia: pode ser solicitada para auxílio diagnostico e estratificação de gravidade quando há acometimento maior que 50% dos campos pulmonares (bilateral) é fator que indica a internação.

Solicitar principalmente em casos em que há queixas de via aérea baixa (falta de ar, alteração de saturação de O2) associadas a sintomas sistêmicos de síndrome gripal (febre, mialgia) ou sinais de acometimento pulmonar (ausculta alterada). Em caso de sintomas como

dor torácica ou febre persistente com tosse produtiva, pode ser solicitado a fim de avaliar complicações, como pneumonia bacteriana ou derrame pleural.

Em quadro de vias aéreas altas, com queixas somente de dor de garganta, coriza, tosse sem dispneia e sem sinais de gravidade, a radiografia pode ser dispensada.

Manejo e prescrição

Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e antitérmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. Diante da possibilidade de síndrome gripal por outros vírus, como a Influenza, indica-se o uso de Oseltamivir nos casos de síndrome gripal e fatores de risco para complicações.

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo acompanhamento ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a comunicação plena com um profissional de saúde da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA durante todo o cuidado doméstico do paciente até a o fim do período de isolamento. A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro devem ser realizados por um profissional da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO COM O AGENTE DE SAÚDE DO TERRITÓRIO, a cada 48 horas, preferencialmente por telefone, solicitando consulta presencial se necessidade de exame físico. SE POUCA MELHORA OU PIORA DO QUADRO.

• **Antitérmico via oral:**

- ✓ 1ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), a cada 4/4 horas ou 6/6 horas a depender da frequência de febre ou dor.
  Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia)
  Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo de 3mg/dia)

- ✓ 2ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/cp) em caso de dor ou febre, de 6/6 horas.
  Crianças > 3 meses: (lactentes 10 mg/kg/dose; pré escolares: 15 mg/kg/dose)
  Adultos: 500-1000 mg VO (dose máxima no adulto 4 gramas por dia)

• **Oseltamivir:**

Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias.
Criança maior de 1 ano:

- ✓ ≤15 kg 30 mg, 12/12h, 5 dias
- ✓ > 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 5 dias
- ✓ > 23 kg a 40 kg 60 mg, 12/12h, 5 dias
- ✓ > 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias

Criança menor de 1 ano de idade:

- ✓ 0 a 8 meses 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias
- ✓ 9 a 11 meses 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias

Condições de risco (recomendação de uso de Oseltamivir):

- Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal).
- Adultos ≥ 60 anos.
- Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade).
- População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso.
- Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye).

- Indivíduos que apresentem: › Pneumopatias (incluindo asma). › Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e possibilidade de reativação). › Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica). › Nefropatias. › Hepatopatias. › Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme). › Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus). › Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares). › Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais de duas semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros. › Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos).

**** Evitar uso de Ibuprofeno. Caso necessário uso de anti-inflamatório preferir outros fármacos (diclofenaco, nimesulida, etc).**

Para todos os pacientes de alta, anotar início dos sintomas, nome e contato para manter monitoramento a cada 48h, prescrever sintomáticos conforme acima e orientar isolamento domiciliar do paciente e dos familiares (fornecer atestado se necessário e termo de declaração).

A opção por prescrição de cloroquina deve estar de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde

O uso de azitromicina pode ser considerado quando há suspeita de infecção bacteriana associada, porém deve-se evitar uso para outras finalidades, principalmente em conjunto com a cloroquina (ambos medicamentos ocasionam alargamento do QT e podem levar a arritmias graves).

Fontes: Protocolo de Manejo de Coronavirus (Covide19) na Atenção Primaria a Saúde Brasilia Distrito Federal. Março 2020 Secretaria de Atenção Primaria a Saúde – Ministério da Saúde
Boletins Epidemiológicos. Secretaria de Vigilância em Saúde Ministério da Saúde

2) PRONTO ATENDIMENTO DE IBITIUVA

Neste serviço também é oferecido atendimento para Sintomáticos Respiratórios do Distrito de Ibitiúva.

- Atendimento de pessoas de 2 anos ou mais.
- Crianças de 0 a 2 anos atender nas Unidades de Saúde.
- Atendimento: Todos os dias da semana inclusive sábados, domingos e feriados das 7:00h às 22:00 h
- Todos os dias das 22:00h às 7:00h Plantão de Unidade de Transporte Tipo A (com motorista e técnico de enfermagem treinados para atendimento e Transporte de Urgência)

Fluxo de atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19 – PA Ibitiúva

O paciente deve passar por triagem na recepção e ser questionado sobre sintomas respiratórios. Em caso de sintomas: febre (mesmo referida), tosse, coriza ou dor de garganta, falta de ar – colocar máscara cirúrgica no paciente imediatamente (se estiver usando máscara de pano substituir pela máscara cirúrgica). O profissional da recepção deverá estar paramentado o tempo todo com máscara PFF2/N95, protetor facial, avental descartável. Após o atendimento de todos os pacientes na triagem deverá realizar rigorosa higiene das mãos e sempre trocar de avental após atendimento de paciente sintomático.

Colocar o paciente em local privativo (consultório exclusivo para uso em pacientes sintomáticos respiratórios), para que não fique na recepção. Avisar ao médico que se trata de atendimento prioritário. Realizar pré-consulta com profissional paramentado devidamente com máscara PFF2, protetor facial, avental descartável e luvas.

Paciente irá passar por atendimento médico (profissional paramentado com máscara PFF2, protetor facial, avental descartável e luvas). Em caso de necessidade de coleta de exames ou realização de medicação, deverá ser feito por técnico ou profissional de enfermagem, no mesmo ambiente da consulta ou em ambiente de observação clínica privativo (sem outros pacientes junto). O técnico que realizou os procedimentos deve estar paramentado (máscara PFF2, protetor facial, avental descartável e luvas), após o atendimento descartar EPIs, higienizar os EPIs reutilizáveis (óculos ou protetor facial) e higienizar rigorosamente as mãos.

O consultório utilizado para o atendimento de sintomáticos respiratórios não deve ser utilizado para atendimento de pacientes com outras queixas. Este consultório deve ser higienizado com frequência (realizar desinfecção com álcool 70% da mesa, cadeiras, maca e maçanetas) e limpo por completo pelo menos ao final de cada turno.

A equipe deve higienizar as mãos constantemente, principalmente após atender pacientes sintomático e antes de atender um paciente que não possui sintomas respiratórios, e permanecer de máscara PFF2 e protetor facial durante todo o expediente. Após o atendimento de sintomáticos respiratórios, estes profissionais devem descartar EPIs, higienizar EPIs reutilizáveis (óculos ou protetor facial) e higienizar as mãos.

Após a consulta o paciente deverá ser liberado para casa ou encaminhado a outra unidade em uso da máscara cirúrgica.

Descrição do atendimento ambulatorial no PA de Ibitiúva

O paciente triado como sintomático respiratório na recepção e já em uso de máscara cirúrgica passará pela pré-consulta, onde serão aferidos sinais vitais (frequência cardíaca e respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, pressão arterial) e irá ser classificado quanto a escala de gravidade. Deverá ser atendido com prioridade pelo médico, no mesmo ambiente da pré-consulta (consultório destinado apenas para os sintomáticos respiratórios).

O médico realizará consulta e, de acordo com a avaliação de gravidade e das características do paciente irá indicar ou não coleta de exames, medicação, liberação ou encaminhamento a outra unidade.

CASOS LEVES:

Casos que não apresentam critérios de internação, porém se encaixam nos sintomas de COVID-19.

Podem ser liberados, orientados a permanecer em isolamento domiciliar[1] por 14 dias e orientados sobre sinais de alarme (falta de ar) e retorno se necessário.

Fornecer atestado com termo de declaração identificando todos os contatos domiciliares, e orientar sinais de alarme e medidas de isolamento domiciliar.

Em casos que não se encaixam nos critérios de coleta ambulatorial (disponível no item coleta de exames), não coletar amostra para exame de PCR ou Teste Rápido e não notificar casos leves, conforme orientação do governo estadual de São Paulo, porém anotar os dados do paciente e passar para a VE municipal para acompanhamento por telefone destes pacientes. Em casos que se encaixem nos critérios, coletar exame conforme dia do início dos sintomas e notificar o caso.

[1]Isolamento domiciliar: não compartilhar objetos pessoais; evitar tocar olhos, nariz ou boca; lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou álcool gel, principalmente após tossir ou espirrar; não receber visitas enquanto sintomas persistirem; proteger a boca e nariz com lenços descartáveis ou cotovelo ao tossir ou espirrar; ficar em quarto sozinho e mantê-lo ventilado; sair de casa somente em situações de emergência e com máscara cirúrgica.

CASOS GRAVES:

Paciente com sinais de insuficiência respiratória aguda ou sepse.

Critérios para SRAG e auxílio na decisão de gravidade:

- Sinais de desconforto respiratório,
- Frequência respiratória > 30 irpm,
- SatO2 ar ambiente < 95%.

Também entra como critério de internação as comorbidades e fragilidade do paciente, além da imagem pulmonar (internar se acometimento >50% dos campos pulmonares na imagem).

Encaminhar estes pacientes a unidade de referência.

Tratamento:

CASOS GRAVES: Serão encaminhados a unidade de referência. Apenas será realizado tratamento de suporte e estabilização do paciente.

CASOS LEVES: Em diretriz publicada em 18 de maio de 2020 pelas Sociedades Brasileiras de Infectologia, Pneumologia e Tisiologia e pela AMIB, não é indicado o uso rotineiro de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, corticóides e Kaletra para o tratamento da doença.

Apesar disso, o Ministério da Saúde lançou novo protocolo de tratamento da COVID-19 em 20 de maio de 2020 no qual indica o uso da cloroquina / hidroxicloroquina em casos leves e moderados, ressaltando que não há evidência de funcionamento da medicação e com a necessidade da discussão médico-paciente e mediante assinatura de termo de consentimento (disponível no manual de tratamento nas pastas no PA e enfermaria) pelo paciente, e sob responsabilidade do médico prescritor.

Em casos graves e pacientes com comorbidades (cardiopatia exceto HAS, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, imunossupressão, neoplasias, HIV/AIDS, doenças neuromusculares, obesidade, tuberculose, pneumopatias), idosos > 60 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso, crianças < 5 anos, menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico) deve ser associado uso de Oseltamivir por 5 dias para tratamento de Influenza, pois esta patologia é de difícil diagnóstico diferencial com COVID-19 (o uso de Oseltamivir não trata a COVID-19).

Doses de medicações:

- Difosfato de Cloroquina:

  D1: 500mg 12/12h (comprimido de 250mg) ou 450mg 12/12h (comprimido de 150mg)

  D2 ao D5: 500 mg 24/24h (comprimido de 250mg) ou 450 mg 24/24h (comprimido de 150mg)

- Sulfato de Hidroxicloroquina:

  D1: 400mg 12/12h

  D2 ao D5: 400mg 24/24h

- Azitromicina: 500mg 24/24h por 5 dias.

- Oseltamivir:
  - 1 comprimido de 75mg a cada 12 horas por 5 dias.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- São contraindicações absolutas ao uso da Hidroxicloroquina: gravidez, retinopatia/ maculopatia secundária ao uso do fármaco já diagnosticada, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia grave.

- Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há interação moderada da hidroxicloroquina com: digoxina (monitorar), ivabradina e propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 220 mg para 110 mg), edoxabana (reduzir dose de 60 mg para 30 mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina.

- Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, estreptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos.

- Devem ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais.

- A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a realização de Eletrocardiograma no primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina com associação eventual com azitromicina.

Coleta de material de via aérea (PCR):

Deve ser realizada entre o 3º e 7º dia de sintomas .De acordo com orientação do MS

- Pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC);

Notificação:

Notificar todos os casos com exames coletados por meio de ficha fornecida pela VE Municipal.

Teste rápido: De acordo com orientações do MS

O teste rápido execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior.

Em caso de profissional assintomático:

Negativo: os profissionais de saúde e segurança ficam aptos a retornar imediatamente ao trabalho.

Positivo: determina afastamento de 14 dias, após o início dos sintomas.

Em caso de paciente sintomático:

Positivo: com quadro clínico e tempo de sintomas compatível, considerar caso confirmado de COVID-19.

Negativo: conferir dias de sintomas, em caso de persistência da suspeita considerar possível erro de exame e não suspender medidas de isolamento.

Notificação:

É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes rápidos. Notificar à VE municipal todos os exames realizados na unidade.

Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso o resultado positivo ou negativo. Essas informações são essenciais para monitoramento da epidemia no Brasil.

3) PRONTO-SOCORRO E PRONTO-ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS

(Específico Plano de Contingencia de Enfrentamento ao Coronavírus - páginas 57 a 89 deste Plano)

Conforme convenio nº 001/2019 estabelecido entre a Prefeitura de Pitangueiras e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pitangueiras e respectivo Plano Operativo que têm por objeto a cooperação entre os convenentes objetivando a contratação da CONVENIADA para a prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial, sem exclusividade, em conformidade com sua capacidade instalada, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências e emergências e a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, a seguir discriminados:

1.1 Atendimento Médico-Ambulatorial de urgência e emergência em regime de pronto-socorro, 24 (vinte e quatro) horas, sete dias na semana, inclusive na prestação dos Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT), e fornecimento de oxigênio e medicação;

1.2 Atendimento Médico-Ambulatorial em regime de Pronto-Atendimento, de 12 (doze) horas aos pacientes SUS, compreendendo o horário das 10h00min às 22h00min, sete dias na semana, compreendendo SADT, oxigênio e medicação;

1.3 Internação hospitalar (procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos) de urgência e eletiva, compreendendo urgência e emergência; Clínica médica; Pediatria;

Ginecologia/obstetrícia; Cirurgia; Traumatologia/Ortopedia e Anestesiologia, inclusive SADT, fornecimento de medicação, oxigênio, alimentação e alimentação especial, se necessário;

1.4 Disponibilização de médicos especialistas em plantão à distância, durante as 24 (vinte e quatro) horas, sete dias na semana, nas especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica geral, clínica cirúrgica, ortopedia/traumatologia e anestesiologia, obedecendo escala previamente elaborada, não podendo estar os dias e horários concomitantes com as escalas médicas de plantões de porta do Pronto-Socorro e Pronto-Atendimento, devendo a mesma ser apresentada à Secretaria Municipal de Saúde e à Comissão de Avaliação e Monitoramento.

1.4.1 O plantão à distância não se confunde com atendimento à distância e o médico, ao ser acionado, deverá comparecer imediatamente ao local de trabalho e, de corpo presente, assumir a condução do caso até o seu término ou estabilização, conforme orientação do CREMESP, disponível em http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario &id=61, com acesso em 9 de julho de 2019.

1.5 Serviço de plantão à distância de profissional biomédico para coleta de exames laboratoriais em esquema de plantão 24 horas, sete dias na semana, para atender pacientes atendidos no Pronto Socorro, no Pronto Atendimento e na internação.

1.6 Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) aos usuários do Sistema Único de Saúde dos atendimentos prestados pela CONVENIADA nas modalidades de atendimento ora contratados, quais sejam, pronto-socorro, pronto-atendimento e internação, inclusive laboratório de Análises Clínicas e Raio X, DESDE QUE ATENDAM AO PROTOCOLO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EXAMES DE URGÊNCIA.

1.7 Serviço de Enfermagem em quantidade suficiente e não cumulativa para atendimento no ambulatório (urgência/emergência) e na internação (urgência e eletiva);

1.8 Atendimento de enfermagem para procedimentos de aerossol, curativos e medicações nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, no período diurno, das 7h às 22h, em continuidade ao tratamento iniciado durante a semana, nas Unidades de Saúde da Rede Municipal;

1.9 O Plano Operativo de metas e indicadores de atenção pactuada, mediante coordenação dos partícipes, objetiva, por meio da CONVENIADA, o cumprimento das metas quantitativas (físicas) e qualitativas para a realização de procedimentos hospitalares, de urgência e emergência e ambulatoriais, definidos no Plano Operativo, como forma de complementação e aprimoramento das ações, serviços e atividades do SUS, devidamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, mediante cooperação técnica e financeira do Município/Secretaria;

Parágrafo único – Os serviços ora conveniados compreendem a utilização pelos usuários do SUS atendidos em função deste convênio em urgência e emergência, pronto atendimento e internação, de pelo menos 60% (sessenta por cento) da capacidade operacional instalada e disponibilizada pela CONVENIADA, incluídos os equipamentos médico-hospitalares utilizados para atendimento da sua clientela particular e as provenientes de convênios com entidades privadas, conforme discriminação abaixo:

a) Todos os recursos instalados e disponibilizados existentes na CONVENIADA de diagnóstico e tratamento;
b) Serviços de Centro Cirúrgico e Obstétrico, incluindo as salas de cirurgias, os materiais e a equipe de enfermagem;
c) Serviços de recepção, enfermagem, limpeza e higienização, rouparia, todos próprios do serviço de hotelaria oferecidos pela CONVENIADA;
d) Alimentação com observância das dietas prescritas pelos médicos assistentes dos pacientes, inclusive dietas especiais;

e) Fornecimento de materiais e medicamentos receitados pelos médicos de uso exclusivo hospitalar e ambulatorial.

4) **OUTROS SERVIÇOS AMBULATORIAIS** de convênios médicos que atendem sintomáticos respiratórios:
   - **SÃO FRANCISCO**
   - **UNIMED,**
   - **SERMED**

(**Planos de Contingencia de Enfrentamento ao Coronavírus de cada um dos convênios – páginas 90 a 104 deste plano).**

Serviços da Rede Municipal de Saúde que atendem pacientes Assintomáticos, estão orientados quanto aos cuidados e referencia para o paciente de COVID-19, e utilizam EPIS

- Unidades Básicas de Saúde Jardim Leone com atendimento Odontológico
- Unidades Básicas de Saúde São João
- Unidades Básicas de Saúde Bela Vista com atendimento Odontológico
- Unidades Básicas de Saúde Central
- Estratégia Saúde da Família Santa Vitoria com atendimento Odontológico
- Estratégia Saúde da Família Ibitiúva com atendimento Odontológico
- Centro de Especialidades
- CAPS
- Serviço de Fisioterapia
- Exames de SADT referenciados para outros serviços: sendo realizados somente em casos de Prioridade e Urgência (a depender do Prestador do Serviço).
- Farmácia Municipal:
  - ✓ Medicação de uso contínuo hipertensão e diabetes - prorrogação da validade da receita, medicações de alto custo - a renovação é imediata e automática por mais três meses até segunda ordem.
  - ✓ Outros medicamentos: A dispensação ocorre na rotina do Serviço.
  - ✓ Medicação para paciente suspeito ou positivo para COVID-19, a família é orientada a buscar o medicamento na Unidade de Saúde.

Atendimentos na Rede Municipal de Saúde:

- Consultas médicas de prioridades, urgência e emergência;
- Consultas de Pré Natal;
- Consultas para obtenção de receitas médicas estão seguindo protocolo da Unidade de saúde;
- Os retornos e exames de rotina de inicio suspensos ,gradativamente estão sendo remarcados dependendo da situação epidemiológica;
- Os atendimentos em grupos estão suspensos;
- Os procedimentos de enfermagem ocorrem de acordo com a prescrição medica.

Orientações paras Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especialidades, durante a pandemia COVID-19

- O Profissional de Saúde (Recepção e Enfermagem) deve estar paramentado o tempo todo com máscara PFF2/N95,e protetor facial.
- O usuário do Serviço de Saúde deve estar de máscara.
- Todo o paciente deve ser acolhido pela Unidade de Saúde.

Sobre agendamento Consultas na Atenção Básica:

- Se o paciente apresentar sintomas respiratórios (febre, mesmo referida, tosse, coriza ou dor de garganta, falta de ar) encaminhar para Unidade Gripal.
- Agendar 03 consultas por horário
- Parte da agenda (50 % consultas agendadas) e parte da agenda (50%demanda espontânea). Esta proporção pode ser de acordo com a realidade da Unidade
- Paciente faltou na consulta terá que ser reagendado,
- Casos de Prioridade e Urgência serão triados pelo Serviço e dado segmento.
- As vagas decorrentes de faltas de pacientes podem ser utilizadas para prioridade, urgência, ou não utilizadas.
- Consultas solicitadas somente para pegar receita, o prontuário pode ser separado e o paciente vir buscar a receita depois.
- Não trazer acompanhante em consultas, EXCETO se a pessoa a ser consultada for criança, idade avançada, ou incapaz.
- Orientar o paciente que fazem tratamento fora do município (HC, RENALS, Hospital Estadual e outros) que os exames laboratoriais só serão autorizados se o retorno já estiver agendado.

Sobre agendamentos Consultas no Centro de Especialidades:

- Se o paciente apresentar sintomas respiratórios (febre ,mesmo referida, tosse, coriza ou dor de garganta, falta de ar) encaminhar para Unidade Gripal
- Agendar 03 consultas por horário.
- Parte das consultas agendadas na Regulação e parte no Serviço, conforme protocolo.
- Paciente faltou na consulta terá que ser reagendado,
- Casos de Prioridade e Urgência serão triados pelo Serviço e dado segmento.
- Quando os serviços de saúde encaminham pacientes para a Especialidade, o formulário de Encaminhamento deve estar completamente preenchido e de acordo com o Protocolo de Especialidade. Formulários incompletos serão devolvidos para o local de origem.

Anexo 1

Protocolo para Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras de Casos Suspeitos de COVID-19.

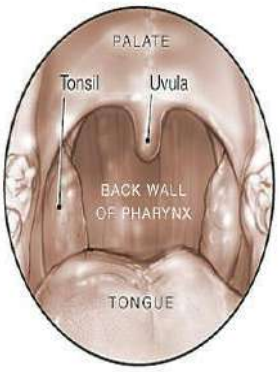


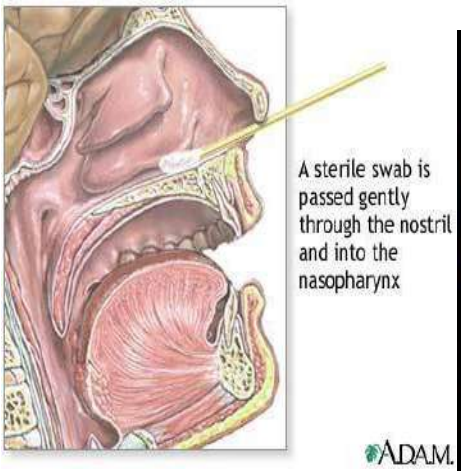
http://www.ial.sp.gov.br/ial/centros-tecnicos/centro-de-virologia/destaques-direita/coronavirus-ncov-2019

- Coletar uma amostra de secreção respiratória (*swab* combinado OU aspirado de nasofaringe OU lavado bronco alveolar);
- A amostra deverá ser coletada até o 7° dia do início dos sintomas, preferencialmente até o 3° dia;
- As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, congelar as amostras a – 70ºC;
- Encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz Central ou Regional com a Ficha de Notificação para casos suspeitos de coronavírus;
- Acondicionar em caixas isotérmicas; os frascos com tampa de rosca e em posição vertical, separados de outros agravos;
- Cadastrar o exame no Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL): campo Agravo-Doença selecionar “influenza-vírus respiratórios” e no campo pesquisa selecionar “Coronavirus (2019- nCoV)”

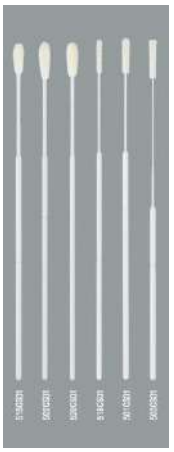












PROTOCOLO LABORATORIAL PARA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DE SRAG E SG POR SARS-CoV-2

Objetivo:
Orientar a realização de coleta, acondicionamento/conservação e transporte de amostras biológicas, com vistas ao diagnóstico laboratorial da COVID-19 em SRAG, SG, óbitos e surtos de SG em comunidades fechadas ou semifechadas, com suspeita de infecção por SARS-CoV-2.

Orientações gerais:

- Certificar-se de que o paciente atende à definição de caso de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou Surto de Síndrome Gripal em comunidades fechadas ou semifechadas:
- Definição de caso de Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.
- Definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

- Definição de Surto de SG em comunidade fechada ou semifechada: Registro de ocorrência de dois casos suspeitos ou confirmados com vínculo epidemiológico, dentro do período de incubação considerado (2 a 14 dias).

Certificar-se da correta notificação de casos:

- Síndrome Gripal (SG): e-SUS VE
  https://notifica.saude.gov.br
- Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG):
  SIVEP-Gripe
  https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe
- Óbitos por SG ou SRAG: SIVEP-Gripe
  https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe
- Surto de SG em comunidade fechada ou semifechada: SINAN
  https://portalsinan.saude.gov.br/surto

A investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2 devem seguir as recomendações de Biossegurança destinadas aos profissionais de saúde que trabalham com agentes infecciosos. Constitui a primeira linha de proteção, os **equipamentos de proteção individual (EPI):**

- Gorro descartável
- Óculos de proteção
- Máscara do tipo N95, FFP2 ou similar
- Luva de procedimento
- Avental de mangas compridas
- Calçados fechados
- Todos os procedimentos técnicos devem ser realizados de modo a minimizar a geração de aerossóis e gotículas.

Estratégia laboratorial:

O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-2 na população sintomática será realizado por RT-PCR em tempo real.

Para os casos de SRAG, óbitos e Surto de SG em comunidade fechada ou semifechada: além do diagnóstico laboratorial para COVID-19, será realizado também o diagnóstico para Influenza.

Em Surtos de SG em comunidade fechada ou semifechada, será permitida a coleta de até 25 amostras/surto.

Para os demais casos de SG, será realizado somente o diagnóstico laboratorial para COVID-19, considerando indivíduos com condição de risco de exposição: profissionais da Saúde, da Segurança Pública, da Limpeza Pública, dos Transportes Públicos e do Sistema Funerário(sepultadores).

Para desenvolvimento de complicações nas infecções por COVID19:

- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Pessoas de qualquer idade com doenças cardiovasculares (cardiopatas, (cardiopatas, insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, HAS), pneumopatias (dependentes de O2, portadores de asma, DPOC), doenças neurológicas (antecedente de AVC, doenças neurológicas degenerativas); nefropatias, doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 ou 5), imunodeprimidos, portadores de doenças cromossômicas,diabetes, obesidade IMC>30;
- Gestantes de alto risco;
- População em situação de vulnerabilidade social (população em situação de rua, quilombolas, povos indígenas)

Oportunidade de coleta:

Considerando que as amostras relacionadas a casos de SRAG, óbitos e a surtos de SG em comunidade fechada ou semifechada serão submetidas a exames para diagnóstico de COVID-19 e de Influenza, a coleta de amostras deve ser realizada quando o paciente está na fase aguda da infecção, entre o 3º e o 7º dia após o início dos sintomas.

Amostras coletadas fora deste período estarão inviáveis para o exame de Influenza e, portanto, não serão processadas para este exame.

Considerando que as amostras relacionadas a casos de SG com condições de risco serão submetidas apenas a exames para diagnóstico de COVID-19, a coleta de amostras poderá ser realizada entre o 3º e o 10º dia após o início dos sintomas.

Coleta:

O processo de coleta é um dos pontos críticos para o resultado do exame. Uma coleta inadequada, com uso do swab na porção mais externa da cavidade nasal ou na língua, leva à obtenção de baixo ou nenhum material viral, que não será detectado mesmo por métodos tão sensíveis como métodos moleculares.

Segundo o CDC, para coleta de amostras de trato respiratório superior devem ser utilizados swabs de fibra sintética (rayon) com haste de plástico. Não devem ser usados swabs de alginato de cálcio ou com hastes de madeira, pois eles podem conter substâncias que inativam alguns vírus e inibem o teste de PCR.

Os protocolos para coletas de amostras de trato respiratório superior para diagnóstico de COVID-19 preconizam o uso de 03 swabs combinados (2 de nasofaringe e 1 de orofaringe), colocados em tubo de tampa de rosca com 3 mL de solução fisiológica estéril. Entretanto, devido à escassez mundial de insumos relacionados à assistência e ao diagnóstico laboratorial de COVID-19 e seguindo as recomendações da OMS e do CDC, a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública recomenda que haja racionalização do uso de swabs, através da utilização de 02 swabs combinados, sendo um para nasofaringe, ou seja, um swab para as duas narinas e um swab para orofaringe, colocados em tubo de tampa de rosca com 3 mL de solução fisiológica estéril.

Em pacientes hospitalizados o MS recomenda a coleta de lavado bronco-alveolar como amostra preferencial ao swab. Por se tratar de procedimento delicado, que requer utilização de equipamentos específicos a coleta deve ser realizada por médicos.

Não inserir qualquer tipo de identificação na haste do swab, para evitar a contaminação do material.

Não utilizar tubos que não tenham tampa de rosca, pois não serão aceitas amostras enviadas em tubos com tampa de pressão.

Cadastro no GAL:

Todas as amostras com suspeita para COVID-19 devem ser cadastradas no GAL.

• Amostras relacionadas a casos de SRAG, óbitos ou a surtos de SG em comunidade fechada ou semifechada devem utilizar as respectivas pesquisas:

- COVID 19 SRAG (caso grave)
- COVID 19 Óbito
- COVID 19 Surto

• Amostras de casos de SG com condições de risco deve utilizar a pesquisa: COVID 19 Síndrome gripal com condição de risco.

Encaminhamento das amostras:

Todas as amostras com suspeita para COVID-19 devem ser encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz – Laboratório Central ou seus Centros de Laboratórios Regionais.

- Amostras relacionadas a casos de SRAG, óbitos ou a surtos de SG em comunidade fechada ou semifechada, serão analisadas somente no Instituto Adolfo Lutz, considerando a realização dos exames paradiagnóstico de COVID-19 e Influenza:
  - Devem estar adequadamente identificadas, de forma a permitir a separação das demais amostras de SG;
  - Devem vir acompanhadas das respectivas fichas de notificação (SIVEP-Gripe ou SINAN), devidamente preenchidas (nos casos de SRAG devem conter informações relacionadas à internação).

- Amostras de casos de SG com condições de risco serão submetidas apenas exame para a identificação de SARS-CoV-2 e serão analisadas no Instituto Adolfo Lutz ou em laboratórios de apoio que compõem a Plataforma de Laboratórios para diagnóstico do Coronavírus (coordenada pelo Instituto Butantan):
  - Devem vir acompanhadas da respectiva ficha de notificação (e-SUSVE).

O prazo de liberação do exame será de até 72 horas da entrega da amostra no laboratório executor. Este prazo poderá ser eventualmente estendido, considerando a necessidade de realizar também a pesquisa para Influenza.

Acondicionamento e transporte das amostras:

As amostras devem ser acondicionadas e transportadas na posição vertical, para garantir que os swabs estarão imersos na solução fisiológica.

Não acondicionar as fichas com os dados do paciente no interior da caixa isotérmica. Segundo recomendações da OMS, as amostras devem ser mantidas refrigeradas (2-8°C) até o processamento. No transporte das amostras ao laboratório deve-se assegurar a manutenção da temperatura.

A embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos ou confirmados com infecção por SARS-CoV-2 deve seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria B.

Critérios para rejeição de amostras:

Amostras encaminhadas em desacordo com as orientações deste documento não serão recebidas:

- Amostras que não estiverem acondicionadas e transportadas na posição vertical; Amostras que não estiverem refrigeradas;
- Amostras que não estiverem em tubo de tampa de rosca;
- Swabs acondicionados em tubos secos, sem os 3 mL de soro fisiológico estéril;
- Amostras coletadas em swabs contendo alginatos ou com haste de madeira;
- Swabs com qualquer tipo de identificação na haste.

Anexo 2

Laboratórios validados para diagnóstico da doença COVID-19:

A lista com os Laboratórios credenciados é atualizada pelo Grupo de Vigilância Estadual de Ribeirão Preto(gve-ribeiraopreto@saude.sp.gov.br) e enviada para os e-mails das Vigilâncias Epidemiológicas municipais

E-mail com a Lista atualizada recebida em 17 de abril de 2020

Fw: Laboratórios validados para diagnóstico da doença COVID-19

Grupo de Vigilância Epidemiológica - GVE XXIV
Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof Alexandre Vranjac" - CVE
Coordenadoria de Controle de Doenças - CCD
Secretaria de Estado da Saúde
Telefones: 16-3607-4226/4248

Atualização dos laboratórios validados para diagnóstico da doença COVID-19:

- IAL Central e Regional
- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP/Instituto Central
- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
- Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto
- Laboratório Análises Clínicas e Patologia do Hospital das Clínicas da UNICAMP
- Hemocentro Botucatu, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu / UNESP
- AFIP
- Laboratório Fleury de São Paulo
- **Hermes Pardini (MG)**
- Laboratório de Virologia do Hospital Israelita Albert Einstein
- Laboratório Sabin Medicina Diagnóstica
- Dasa (Marcas: Alta, Delboni Auriemo, Labsim, Cytolab, Vital Brasil, Salomão Zoppi, Laboratório Oswaldo Cruz, Lavosier, Deliberato, Previlab, ValeClin e Padrão Ribeirão Medicina Diagnóstica)
- DB Diagnóstico - DB Molecular
- Instituto Butantan
- Instituto de Análises Clínicas de Santos
- Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
- Centro de Análises e Tipagem de Genomas Ltda
- Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa
- Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo
- Instituto de Biologia do Exército (RJ) - credenciamento anexo
- São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica S/A (MG)
- Laboratório de Imunologia Clínica e Biologia Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - UNESP
- Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores Labzoo/DVZ/Covisa/SMS
- Diagnósticos da América S.A.
- Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário Saúde ABC
- Laboratório de Patologia Cirúrgica de São Paulo
- Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
- Inside Diagnósticos S.A.

Anexo 3

Orientações para o Procedimento Emissão de Declaração de Óbitos frente a Pandemia do COVID-19, no Estado de São Paulo

Considerando que: O Estado de São Paulo representa neste momento o epicentro da doença COVID-19, em território nacional, estando ainda na fase logarítmica de disseminação com aumento diário significativo de novos casos;

A Declaração de Óbito deverá ser preenchida pelo médico que assistiu ao paciente, seguindo as diretrizes dos artigos 21, 83 e 84 do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina: Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Art. 83. Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal. Art. 84. Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta/suspeita;

Que as determinações da Organização Mundial de Saúde desaconselham a realização de autópsia para casos suspeitos e confirmados de COVID-19;

Que, em situação de pandemia, quaisquer corpos podem ser considerados de risco para contaminação e difusão da doença;

Que o exame por RT-PCR para COVID-19, tem sido utilizado para confirmação de
casos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo orienta:

1 – Casos confirmados de COVID-19 deverão ter a Declaração de Óbito (DO) preenchida como bem-definido seguindo as Orientações de Preenchimento da DO **Anexo I**.

2 – Casos de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico e casos suspeitos de COVID-19 com investigação em andamento devem colher swab nasal / orofaríngeo post- mortem (até 24 horas após o óbito), caso não tenha material colhido em vida – **Anexo II** e preencher a Declaração de Óbito como “Morte a Esclarecer – aguarda exames”.

3 – Demais casos – Deve ter a Declaração de Óbito preenchida pelo médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito, preencher como:

A- Se as informações disponíveis no prontuário e as informações fornecidas por familiares, possibilitarem a identificação da causa de óbito (ainda que quadro sindrômico) o médico deverá preencher a DO com estas informações.

B- Em situações que as informações do item A, não permitirem, minimamente, a definição de uma causa a DO deve ser preenchida como “Morte Indeterminada – aplicada autópsia verbal”. Aplica-se o Questionário de Autópsia Verbal - **Anexo III** Disponível em: www.ccd.saude.sp.gov.br, que deverá ser impresso e preenchido manualmente.

Os casos não devem ser encaminhados para autópsia nos SVOs durante o período de Pandemia de COVID-19.

O manejo do corpo de ser feito seguindo a resolução SS 28 de 25/02/2013 que “Aprova Norma Técnica que disciplina os serviços de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somatoconservação de cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e transladação, e dá outras providências.”

A**nexo IV** Todos os profissionais envolvidos no manejo do corpo deverão utilizar os equipamentos de proteção individual descritos no item 6.24 da Resolução SS 28 de 25/02/2013.

Adicionalmente, os corpos de casos descritos nos itens 1, 2 e 3 desta orientação, devem ser acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de acordo com a política nacional de resíduos e desta forma colocado e mantidos na urna.

Resolução SS 28 de 25/2/2013 - Aprova Norma Técnica que disciplina os serviços de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somatoconservação de cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e transladação, e dá outras providências.

Anexo 4

Portaria nº 454, DE 20 de março de 2020

Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19).Diário Oficial da União Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, tendo em vista o disposto no § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar; e

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à pandemia do coronavírus (covid-19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, resolve:

Art. 1º Fica declarado, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19).

Art. 2º Para contenção da transmissibilidade do covid-19, deverá ser adotada como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quartorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se pessoa com sintomas respiratórios a apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que seja confirmado por atestado médico.

Art. 3º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, considerando os sintomas respiratórios ou o resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.

§ 1º O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

§ 2º Para emissão dos atestados médicos de que trata o § 1º, é dever da pessoa sintomática informar ao profissional médico o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão de fato ou prestação de informações falsas.

§ 3º Para as pessoas assintomáticas que residem com a pessoa sintomática será possível a emissão de novo atestado médico de isolamento caso venham a manifestar os sintomas respiratórios previstos no parágrafo único do art. 2º ou tenham resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.

§ 4º A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes documentos assinados pela pessoa sintomática:

I - termo de consentimento livre e esclarecido de que trata o § 4º do art. 3º da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020; e

II - termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam ou trabalhem no mesmo endereço, nos termos do Anexo.

Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente

necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas .
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Termo de Declaração:

Eu,_____
RG : _____
CPF :_____

Residente em_____
Declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início _____, previsão de término _____

Local de cumprimento da medida _____

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar:

1._____

2._____

3._____

Assinatura da pessoa sintomática:
_____

Data: _____/_____/_____ Hora: _____: _____

Anexo 5

Determinações:

- Sobre reutilização da máscara N95 ou similar em tempos de escassez de EPI:

Visando maior segurança do profissional de saúde, em caso de regularização do estoque de máscaras N95 ou similar, deve-se seguir orientação de reutilização concomitante com o protetor facial por no máximo 15 dias (em contrapartida a orientação anterior, que indicava 30 dias de uso).

Conforme protocolo já estabelecido, para a reutilização deve-se seguir rigorosamente inspeção visual e teste de vedação (inspiração e expiração).

Em caso de dano estrutural, contaminação ou vedação inadequada descartar imediatamente a máscara e não reutilizar.

Para reutilização da máscara é necessário manuseio correto evitando contaminação da parte interna.

Higienização das mãos antes e após manuseio da máscara e guardar a máscara em recipiente plástico ou de papel não mantendo hermeticamente fechado (conter abertura ou furos) para evitar umedecimento da máscara.

REFERÊNCIA: RECOMENDAÇÕES Da Secretaria Municipal de Pitangueiras baseada na SBPT SOBRE USO DE MÁSCARAS NO ÂMBITO DA COVID-19

- Sobre a nebulização de ambientes externos: Conforme Nota técnica 34/2020 ANVISA, não tem sido recomendada, mas visto adesão de vários municípios, orienta-se: uso de hipoclorito de sódio na concentração 0,5% (produto corrosivo, pode causar irritações na pele), equipamentos para dispensação conforme consta no rótulo. EPIs: luva, máscara, proteção ocular, avental compatível com o produto dispensado.

- Sobre aventais: conforme RDC 356/2020 ANVISA, o avental deve ser confeccionado de TNT odonto-médico, gramatura mínima 30 (impermeável gramatura 50), devendo ser descartado e trocado após atendimento a paciente suspeito. Deve possuir punho. Não utilizar avental de plástico em áreas com pacientes suspeitos.

- Para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios que sejam suspeitos para COVID-19, deve-se utilizar avental de TNT para uso odonto-médico, e deve ser trocado após atendimento do paciente suspeito.

- Para locais que utilizam o macacão, utilizar avental por cima ao transportar paciente suspeito (SAMU).Os macacões usados pelo SAMU para atendimento de casos suspeitos ou confirmados devem ser descartados após o uso, não podendo fazer reutilização.

- Diante da escassez de EPI, os aventais de plástico podem ser utilizados para ultrassom, blitz e procedimentos em pacientes não suspeitos ou confirmados para COVID.

- Os sepultadores, que usam o macacão em casos suspeitos ou confirmados devem descartar o mesmo após cada uso.

- Sobre inquérito em profissionais de saúde e segurança: conforme nota técnica 97/2020 ANVISA, com orientações específicas para realização de teste rápido em farmácias, devem ser seguidas normas de boas práticas e conforme perguntas e respostas da ANVISA sobre testes rápidos, estes devem ser feitos em unidades ambulatoriais ou hospitalares.

Fonte: Em atenção as determinações da ANVISA, Determinações da Dra Maria Rita Margarido - Medica Infectologista

Anexo 6

ATESTADO MÉDICO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR

Atesto para fins trabalhistas, que o(a) Sr.(a) _____, compareceu ao atendimento médico na Unidade Gripal de Pitangueiras - São Paulo, no dia ____/___/20___, CID Z290. Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância nacional, declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020; seguindo as diretivas da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que regulamenta medidas de isolamento domiciliar; e seguindo, ainda, a Portaria Interministerial nº 5 de 17 de março de 2020, determina caráter compulsório das medidas de enfrentamento à Covid-19; declaro que o(a) paciente acima deve permanecer em ISOLAMENTO DOMICILIAR pelo período de 14 DIAS, a contar do dia de hoje.

Desta forma, essas pessoas também deverão permanecer em isolamento domiciliar por igual período.

CID:_____

Pitangueiras, _____ de _____ de 20___

Horário: ___:____

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar:

- _____
- _____
- _____

_____ _____

Médico **Paciente**

ANEXO 7

Inquérito da Covid-19: Aplicação de teste rápidos para em Profissionais da Saúde do Município de Pitangueiras que atendem em Pronto Atendimento, Urgência e Emergência

Realizado pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Epidemiológica nos dias 26, 27, 28, 29 de maio e 02 de junho de 2020

Objetivo: Testar os profissionais do Serviço Saúde Gripal, PA de Ibitiúva, PA Santa Casa de Pitangueiras ,SAMU e Transporte, Vigilância Epidemiológica, Farmácia de Pitangueiras e Ibitiúva e avaliar a situação epidemiológica dos trabalhadores da Saúde na assistência, identificando se o trabalhador já entrou ou ainda não entrou em contato com o coronavírus e possui anticorpos para a doença.

Os resultados coletados contribuem para o planejamento das ações em relação a Recursos
Humanos, avaliação de eficácia de EPI e revisão de estratégicas no combate à Covid-19.

Observado que da clientela testada, 22 profissionais, 24 profissionais têm comorbidades como: DPOC, Asma Brônquica, Bronquite, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes e Gastrostomia.

A amostra esta identificada por sexo, faixa etária, local de trabalho e local de moradia de cada profissional da saúde.

Observações: Os profissionais testados que trabalham nas UBS e CSE também trabalham em plantões de finais de semana feriados no PA de Ibitiúva. Os profissionais testados da SMS trabalham na Vigilância Epidemiológica e Farmácia Municipal.

Tabelas: Distribuição dos Profissionais por faixa etária e endereço, local de trabalho e comorbidades :

Fonte: Vigilância Epidemiologica de Pitangueiras

		%	Leste	Norte	Oeste	Sul	Ibitiúva	Outros Municípios	Total
Testes por Região de Moradia			36	30	10	18	16	12	122
%			29,5%	24,5%	8,1%	14,7%	13,1%	9,8%	100%
Sexo	Masculino	39,3%	18	09	06	04	03	08	48
	Feminino	59,8%	18	21	04	14	13	04	73
Faixa etária	00 a 09	00%							00
	10 a 19	1,6%							02
	20 a 29	13,9%							17
	30 a 39	34,4%							42
	40 a 49	22,9%							28
	50 a 59	21,3%							26
	60 a 69	5,7%							07
	70 a 79	00%							00
	80 a 89	00%							00
	90 a 99	00%							00
Profissional da saúde	Sim	100%							122
	Não	00%							00
Comorbidade	Sim	25,4%							31
	Não	74,5%							91
SAMU		13,1%							16
Central		9%							11
Secretaria de Saúde		17,2%							21
Santa Casa		35,2%							43
C.S.E.		1,6%							02
U.B.S. Bela Vista		0,8%							01
U.B.S. Jardim Leone		00%							00
U.B.S. Santa Vitória		2,4%							03
U.B.S. São João		1,6%							02
P.A. Ibitiúva		18%							22
Resultado da Testagem	Positivo	00%							00
	Negativo	100%							122

Zona Sul									
Jd. Macedo	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	02	00	00	00	00	02
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Bela vista	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	02	00	00	00	00	00	02
M		00	00	00	00	01	00	00	01
Res. Morada do Sol	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	02	02	02	00	00	07
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Alvorada	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	00	00	00	00	00	01
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Vila Thomazini	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	01	00	00	00	02
M		00	01	01	00	00	01	00	03

Zona Oeste									
Jd. Canadá	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	00	01	00	00	01
M		00	00	00	01	00	00	00	01
Jd. Paraíso	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	00	00	01	00	00	01
Conj. Hab. Plácido Horth	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	01	00	00	02
M		00	00	02	01	01	00	00	04

Zona Norte									
Jd. Botânico	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Das Pitangueiras	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	01	00	00	00	01
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Sta. Tereza	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	01	00	00	00	00	01
Jd. Gumercindo Hentz Soares II	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	01	00	00	00	01
M		00	00	01	00	01	00	00	02
Vila Caroni	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	01	01	01	00	00	04
M		01	00	00	00	00	01	00	02
São Gabriel	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	00	00	00	00	00
M		00	00	01	00	00	00	00	01
Jd. Gumercindo Hentz Soares	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	02	01	01	02	00	00	06
M		00	00	00	00	01	00	00	01
Jd. São Heitor	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	01	00	00	02
M		00	00	00	01	00	00	00	01
Jd. Leoni	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	03	01	01	00	00	05
M		00	00	00	01	00	00	00	01

Zona Leste									
Jd. Paulista	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	00	02	01	00	00	03
Jd. São João	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	00	00	00	00	00
M		00	00	01	00	00	00	00	01
Jd. Sumaré	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	01	01	00	00	00	03
M		00	00	00	02	00	00	00	02
Jd. São Benedito	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	03	00	00	00	00	04
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Sto. Antônio	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	00	01	00	01	00	02
Jd. Brasília	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	00	02	00	00	00	02
M		00	00	00	00	00	00	00	00
Jd. Pedro de Felício	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	01	00	00	00	00	01
M		00	00	00	00	01	00	00	01
Centro	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	01	01	03	00	00	06
M		01	01	02	01	02	02	00	09
Ibitiúva	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	01	06	03	02	01	00	13
M		00	00	00	01	01	01	00	03
Outros Municípios	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
F		00	00	02	01	01	00	00	04
M		00	04	02	01	01	00	00	08
Total	Faixa Etária	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	Total
		02	**17**	**42**	**28**	**26**	**07**	**00**	**122**
Feminino		**00**	**11**	**31**	**16**	**15**	**01**	**00**	**74**
Masculino		**02**	**06**	**11**	**12**	**11**	**06**	**00**	**48**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 633 – Centro – CEP 14.700-000
E-Mail: smspitangueiras@hotmail.com

Tabela Testes rápidos realizados em trabalhadores da Saúde nas Unidades de Saúde da SMS:

Observação: inquérito realizado em duas etapas (maio e junho e julho)
Alguns profissionais expostos a maior risco, realizaram o Teste nas duas oportunidades .
Na tabela 1º data identificado em amarelo e 2º data identificado em azul

Unidade	Data	Testes	Negativo	Positivo	Conduta	Observação
SAMU e Transporte	26 a 30/05	23	23	0	Orientados e liberados	Nesta Unidade um profissional Sintomático com PCR Positivo, após a data da realização do teste rápido.
PA e Farmácia Ibitiuva	26 a 30/05	32	32	0	Orientados e liberados	
Unidade Gripal	26 a 30/05 Junho	11 7	11 7	0 0	Orientados e liberados Orientados e liberados	Alguns funcionários foram admitidos depois da data da primeira etapa de realização do teste.
Santa Casa	26 a 30/05 julho	50 68	50 67	0 1	Orientados e liberados Orientados e liberados	A Santa Casa assumiu a realização do 2º Inquérito realizado em julho 2020 Neste um profissional assintomático ,que também trabalha na Rede Publica testou IgM Positivo . Este profissional repetiu o teste 10 dias após e testou IgM negativo e IgG negativo .
UBS São João	01/07	12	12	0	Orientados e liberados	Nesta Unidade, antes do inquérito dois profissionais sintomáticos com PCR positivos . Não realizaram teste rápido.
UBS jardim Leone	02 a 04/07	25	25	0	Orientados e liberados	Nesta Unidade antes do inquérito um profissional sintomático PCR positivo.Não realizou teste rápido.
CAPS	06/07	10	10	0	Orientados e liberados	
UBS Bela Vista	02 a 04/07	26	26	0	Orientados e liberados	Nesta Unidade , antes do inquérito um profissional assintomatico testou IgG positivo (Fez Teste na Santa Casa de Ribeirão Preto) Não repetiu a sorologia .
ESF 1 e 2 Santa Vitoria	02 a 04/07	33	33	0	Orientados e liberados	
PSF Ibitiuva , Fisioterapia e Farmácia	02 a 04/07	17	17	0	Orientados e liberados	
CSE e Melhor em Casa	02 a 04/07	27	27	0	Orientados e liberados	
UBS Central	02 a 04/07	12	12	0	Orientados e liberados	
Farmácia e	02 a	10	10	0	Orientados e	

Almoxarifado	04/07				liberados	_
Fisioterapia	02 a 04/07	7	7	0	Orientados e liberados	
Vig. Epidemiológica	26/04 13/07	3 6	3 6	0 0	Orientados e liberados	
VISA	26/04 13/07	1 6	1 5	0 1	Orientado e liberados	Um profissional assintomático testou IgM positivo e IgG negativo. Após realizou Sorologia (Lab particular) resultado Negativo.
Controle de Endemias	26/04 14/07	2 13	2 13	0 0	Orientados e liberados	
SMS	13/07	23	23	0	Orientados e liberados	
Serviço Social	16/07	91	90	01	Orientados e liberados	Um profissional positivo 14 dias antes do inquérito. Fez o teste rápido e testou IgG positivo e IgM negativo
Segurança	07 a 15/07 2020	72	72	0	Orientados e liberados	

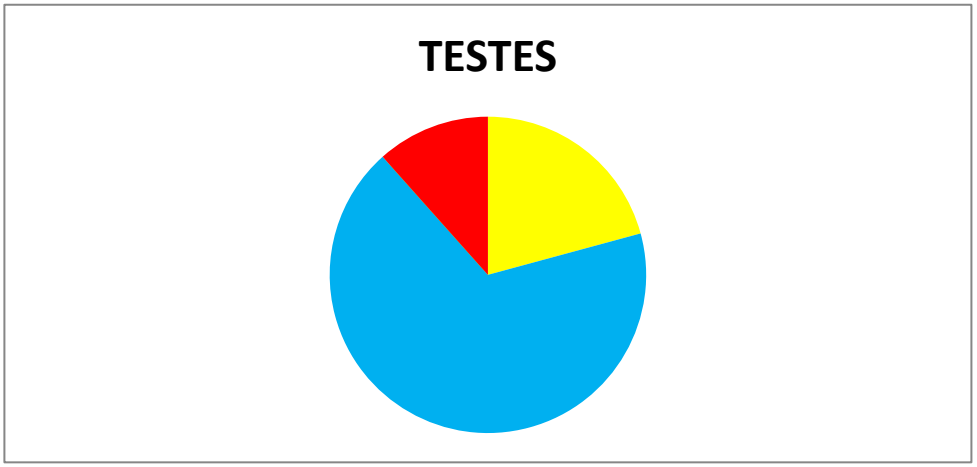
Testes rápido para detecção COVID-19 Realizados pela Secretaria Municipal de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, CAPS, PA de Ibitiuva, no Serviço Social e Segurança Pública

1º Inquérito: (26 a 30/05/2020) : 122 exames

2º Inquérito: (Junho e Julho 2020): 397 exames

2º Inquerito Santa Casa 68 (exames realizados pela Santa Casa): 465 exames

Total de Testes realizado: 587 testes



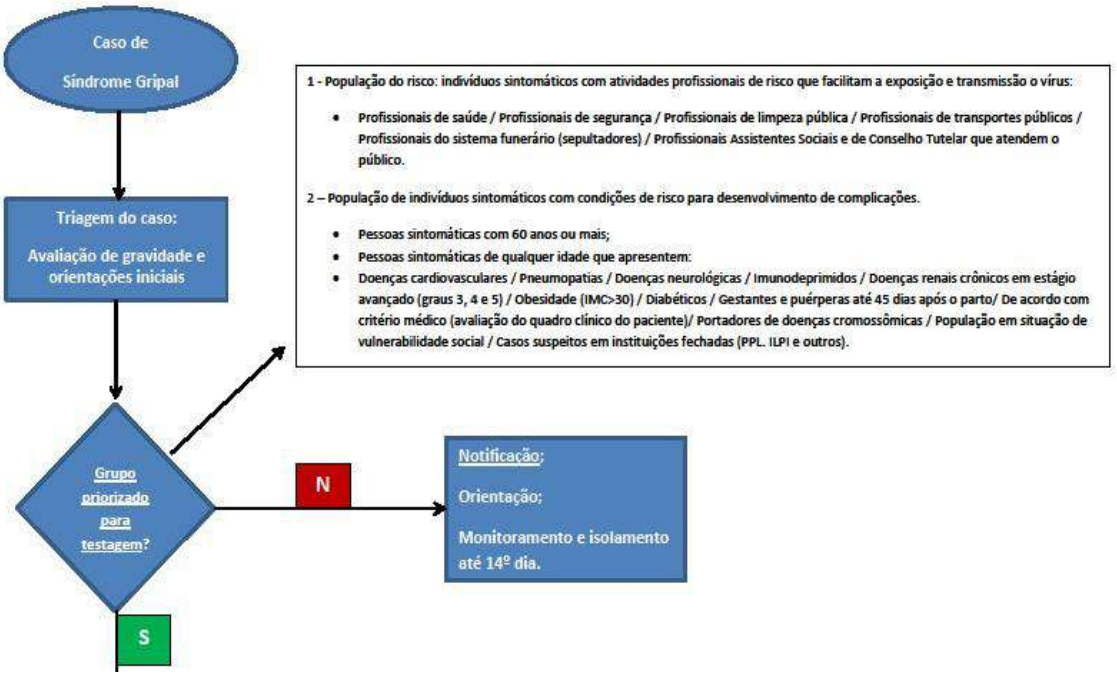
Legenda:

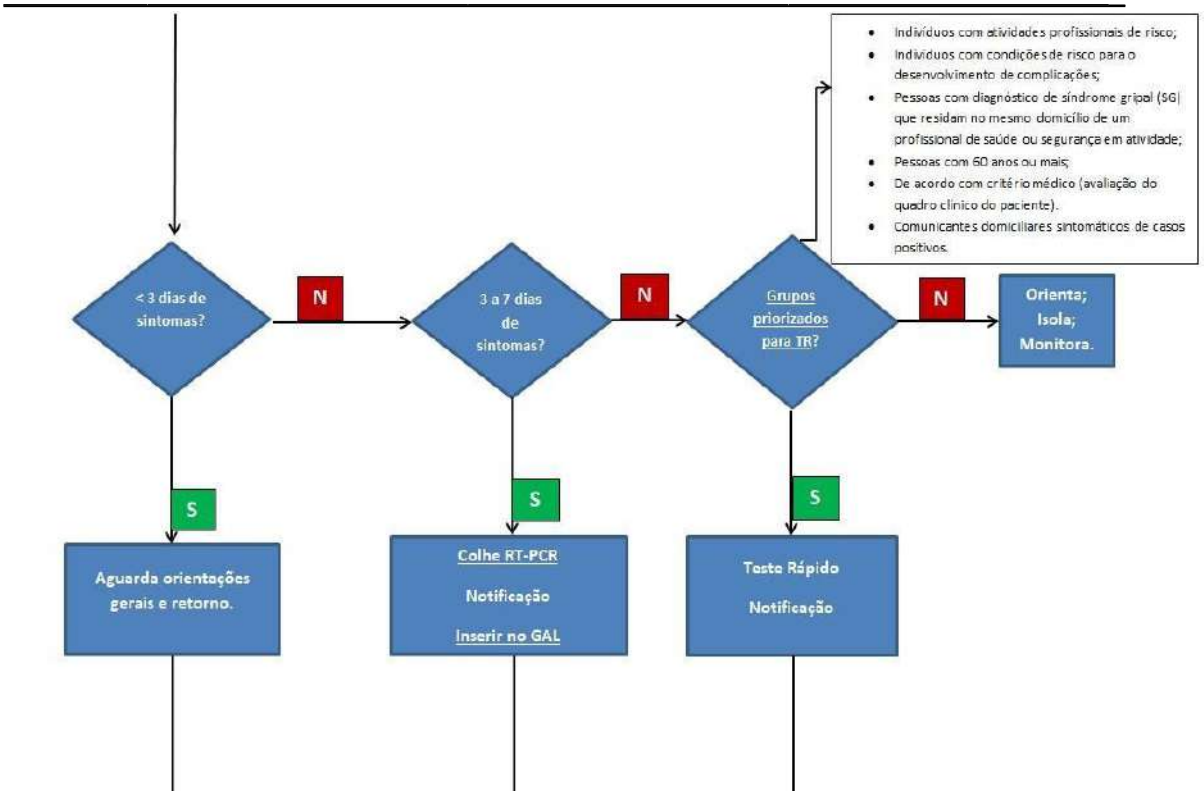
Amarelo : 1ª Etapa Testes SMS Vermelho: 2° Etapa testes da Santa Casa

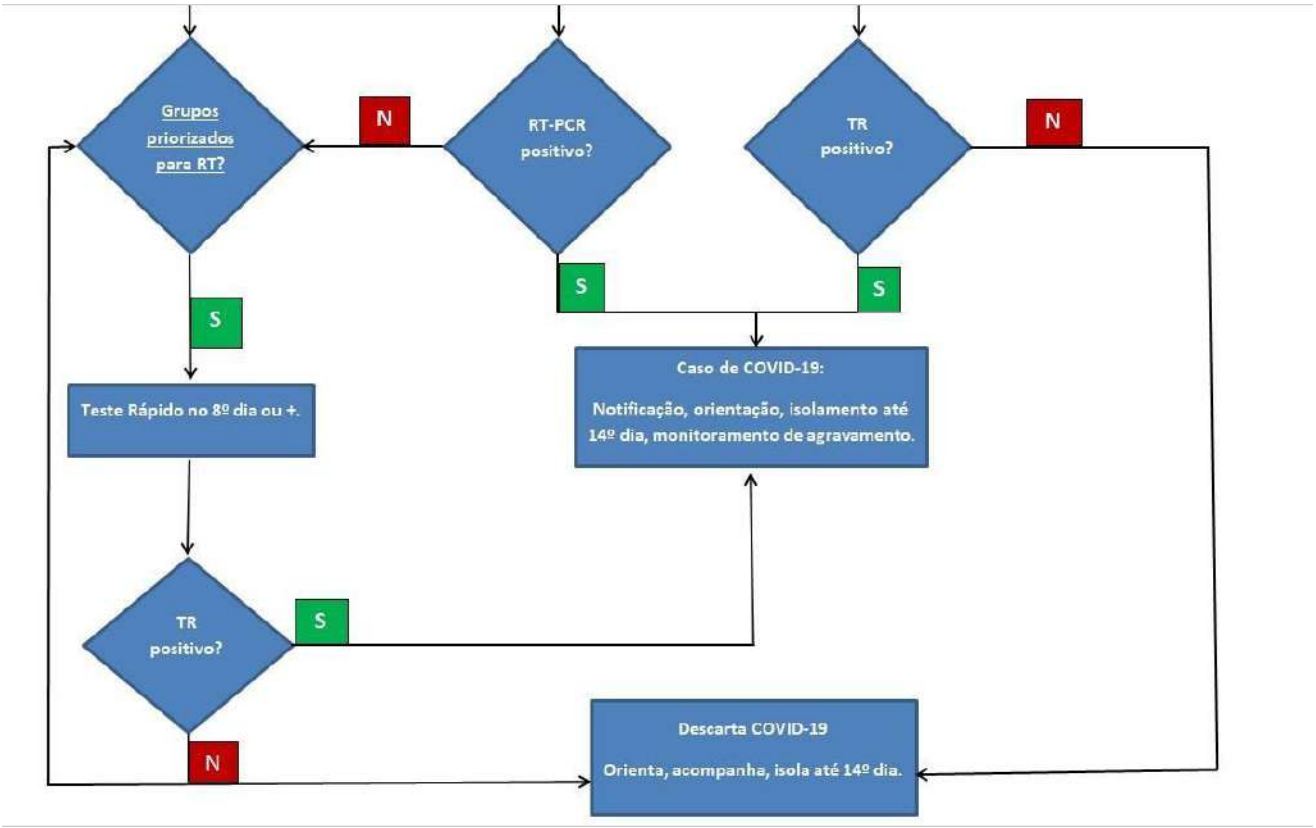
Azul : 2ª Etapa Testes SMS, Serviço Social e Segurança Publica

Anexo 8

Fluxograma para Investigação Laboratorial




< 3 dias de sintomas?
N
3 a 7 dias de sintomas?
N
Grupos priorizados para TR?
N
Orienta; Isola; Monitora.
Indivíduos com atividades profissionais de risco;
Indivíduos com condições de risco para o desenvolvimento de complicações;
Pessoas com diagnóstico de síndrome gripal (SG) que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade;
Pessoas com 60 anos ou mais;
De acordo com critério médico (avaliação do quadro clínico do paciente).
Comunicantes domiciliares sintomáticos de casos positivos.
S
Aguarda orientações gerais e retorno.
S
Colhe RT-PCR
Notificação
Inserir no GAL
S
Teste Rápido
Notificação


Grupos priorizados para RT?
N
RT-PCR positivo?
TR positivo?
N
S
S
S
Teste Rápido no 8º dia ou +.
Caso de COVID-19:
Notificação, orientação, isolamento até 14º dia, monitoramento de agravamento.
TR positivo?
S
N
Descarta COVID-19
Orienta, acompanha, isola até 14º dia.

Anexo 9

Protocolo de realização de exames (PCR e Teste rápido) em empresas particulares e farmácias

A realização de exames diagnósticos para COVID 19 deve seguir as orientações do Ministério da Saúde e ANVISA idealmente, portanto não deve ser feita de forma indiscriminada.

O exame deve ser indicado por um profissional médico, portanto o exame só deve ser realizado mediante um pedido pelo médico.

Todos os exames realizados devem ser prontamente notificados à Vigilância Epidemiológica municipal.

É obrigatório o cumprimento de medidas de segurança no laboratório, conforme descritas pela ANVISA, principalmente o uso de EPIs pelos profissionais.

No caso de exames particulares, os exames podem ser feitos em pacientes que não apresentem critérios sugeridos pelo Ministério, desde que com pedido médico. Porém, para ciência, seguem os critérios do MS:

Definições:

- Caso de Síndrome Gripal (SG):

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.

- Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG):

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
Em Crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

- Surto de SG em comunidade fechada ou semifechada:

Registro de ocorrência de dois casos suspeitos ou confirmados com vínculo epidemiológico, dentro do período de incubação considerado (2 a 14 dias).

Exames:

- Testes rápidos sorológicos para SARS-CoV-2: devem ser realizados à partir do 10º dia do início dos sintomas.

–

- Teste PCR (Coleta de Swab de Orofaringe): do 3º ao 7º dia do início dos sintomas.

Como notificar:

Após a realização do exame, deve ser preenchida ficha de notificação disponibilizada pela VE municipal, identificando o paciente, data de início dos sintomas, data da coleta, qual o exame foi realizado e quais os sintomas presentes.

A ficha deve ser enviada para a VE municipal.

Resultado:

O resultado deve ser explicado e fornecido pelo médico que solicitou o exame. O paciente deve passar em consulta médica para verificar o resultado, uma vez que em casos positivos deve receber orientações médicas e afastamento de atividades laborais.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 633 – Centro – CEP 14.700-000
E-Mail: smspitangueiras@hotmail.com

Anexo 10

Informativo para quem está com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus COVID-19 SMS de Pitangueiras

Isolamento Domiciliar

Fique em casa: Sozinho no quarto e **deixe as janelas abertas para ventilar o ambiente**
Se andar em ambientes comuns da casa (banheiro, cozinha, sala) **usar mascara comum.**
Não receba visitas
Cubra a boca e o nariz durante tosse e espirro com lenços descartáveis, jogue fora imediatamente o lenço utilizado, ou tossir sobre o cotovelo. Lavar as mãos logo a seguir.
Lave as mãos com água e sabão varias vezes ao dia antes e após : comer, utilizar o banheiro, tocar objetos da casa.
Não compartilhe objetos pessoais (talheres, copos, pratos toalhas)
Lave talheres e outros objetos **com agua e sabão**
Se tem um cuidador, o mesmo deve utilizar mascara o tempo todo e utilizar luvas ao lidar com secreções da boca,nariz,fezes e urina.
Utilize luvas também para limpeza e manipulação de superfícies com possível contaminação pela pessoa doente.
Acondicione todos os lixos gerados pelo paciente ou com o seu cuidado em saco plástico, em lixeira no quarto do paciente, antes de dar seu destino final.
Limpe com álcool liquido varias vezes ao dia as superfícies mais tocadas pelo doente.
Limpe o piso com agua sanitária.
Roupas, toalhas e roupas de cama devem ser **lavadas separadamente com agua e sabão comum.**
Todas as pessoas que residem no mesmo endereço devem manter também isolamento, ficar em casa nos outros cômodos da casa.
Não sair de casa para ir a bancos, supermercados, comercio, vizinhos. Pedir para outra pessoa fazer suas compras.
O isolamento é de 14 dias.
Crianças não podem brincar na rua, ou com outras crianças que não morem no domicilio.

Procurar atendimento imediato se os sintomas se agravarem:

Locais de atendimento: Unidade Gripal (Rua Minas nº 253) das 700 às 1900 horas de 2ª a 6ª feira.
Santa Casa de Pitangueiras: À noite, sábados, domingos e feriados.
Pronto Atendimento de Ibitiúva : diariamente das 7:00 às 22:00 hs.

Anexo 11

Outras Medidas Profiláticas

- Sanitização de ambientes, medida de prevenção contra a COVID-19. Realizada pela equipe do Controle de endemias, conforme normatização em prédios públicos e nas Unidades de Saúde.

- Mutirão de prevenção com Equipes nas entradas da cidade e Distrito com orientações sobre a doença COVID-19, uso de mascaras, higienização de mãoes, isolamento social, verificação de temperatura e se necessário encaminhamento para a Unidade de Atendimento Gripal.

- Treinamento de equipes de trabalho em relação ao Uso de EPI.

Anexo 12-

Relatório de Inspeção VISA Municipal

Relatório das Inspeções realizadas pelo Serviço Municipal de Vigilância Sanitária durante o período de Pandemia Covid-19, com ênfase em medidas sanitárias e adequações para o funcionamento de atividades econômicas durante o período de situação de Calamidade Pública de acordo com os Decretos Municipais e Estaduais vigentes durante o período de 19/06/2020 à 17/07/2020.

Informamos que foram visitados 130 (cento e trinta) estabelecimentos no qual foram orientados quanto ao Decreto Municipal nº 4.283 de 01 de Junho de 2020, quanto:

I - Manter controle de acesso único, com um funcionário presente, mantendo-se as outras portas abertas para circulação de ar, mas impedidas de uso para acesso;

II - Disponibilizar álcool em gel ou lavatórios na entrada e distribuídos no interior do estabelecimento, inclusive;

III - Orientar o público para manter distância mínima de 2 (dois) metros entre os presentes;

IV - Promover higienização constante dos locais onde possa haver contato manual dos clientes e funcionários;

V - Manter os funcionários com uso de equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras e luvas;

VI - Em caso de fila de espera interna ou externa, manter funcionário para orientar o distanciamento de 2 (dois) metros entre os clientes, com marcação de solo;

VII - Afixar em lugar visível o número permitido de pessoas que possam permanecer no local;

VIII - Orientar os clientes sobre o uso de máscara, e fornecê-la se necessário.

IX - Fica impedido o consumo interno e externo de alimentos e bebidas.

Foram ainda orientados esses estabelecimentos quanto ao Decreto 64.959 de 04/05/2020 e Resolução SS 96, de 29 de Junho de 2020, quanto ao uso obrigatório de Máscaras.

Relatório das Inspeções realizadas pelo Serviço Municipal de Vigilância Sanitária durante o período de Pandemia Covid-19, com ênfase em medidas sanitárias e adequações para o funcionamento de atividades econômicas durante o período de situação de Calamidade Pública de acordo com os Decretos Municipais e Estaduais vigentes durante o período de 15/03/2020 à 18/06/2020.

- Estabelecimentos Visitados 190 (Cento e Noventa)
- Estabelecimentos Notificados: 88 (Oitenta e Oito).

FONTE: VISA Municipal
Pitangueiras, 20 de Julho de 2020.

Anexo 13:

RESUMO DA DELIBERAÇÃO CIB 55:

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB ESTADO DE SÃO PAULO
Deliberação CIB nº. 55/2020
Considerando o cenário epidemiológico da COVID-19 no Estado de São Paulo;
Considerando que a ampliação da realização de testes diagnósticos e oportuna identificação de casos é instrumento vital para conhecimento da trajetória da doença nos municípios do Estado do São Paulo e evitar a propagação viral mais deletéria, visando à mitigação e combate à epidemia;
Considerando a iniciativa da SES e definição conjunta com o COSEMS-SP quanto à ampliação de diagnóstico laboratorial por meio do RT- PCR tendo em vista, a nova definição de caso de Síndrome Gripal, propondo estratégia integrada entre Vigilância e Assistência possibilitando a detecção precoce de casos e o cuidado ambulatorial ,evitando o agravamento do quadro clínico dos pacientes e, possíveis internações hospitalares;
Considerando a necessidade de detecção e diagnóstico dos casos, rastreamento de contatos e monitoramento de ambos;
Considerando a diversidade de Testes Rápidos (TR) aprovados pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde com características variadas e indicações para diferentes contextos;
Considerando que os exames RT PCR e Teste Rápido (TR) são complementares e devem ser utilizados num algoritmo de decisão, frente a cada situação específica dependente do indivíduo que será testado e da situação epidemiológica vigente;
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP aprovou em sua 301ª reunião ordinária a Nota Técnica CIB: Orientações para os serviços de saúde sobre a utilização e interpretação dos testes rápidos para a COVID-19 e padronização das condutas de isolamento, conforme Anexo I.

São Paulo, 01 de julho de 2020.
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário de Estado da Saúde
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite – CIB-SP

SINTOMÁTICOS
Recomendações

Definição de caso de suspeitos de síndrome gripal:

Síndrome Gripal característica de COVID-19: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por **sensação febril ou febre**, mesmo que relatada, **acompanhada de** tosse **OU** dor de garganta **OU** coriza **OU** dificuldade respiratória **OU** ausência de paladar **OU** ausência de olfato.

Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Em idosos: a febre pode estar ausente. Considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Para todo indivíduo sintomático independente de grupo de risco:

A - COLETA:

RT-PCR - Coleta do 3º ao 7º dia da data de início de sintomas. Encaminhar as amostras ao IAL com cópia da ficha de notificação e protocolo no GAL.

Teste Rápido e sorologia - Coleta após 7º dia de início de sintomas, preferencialmente a partir do 14º dia.

B - RESULTADOS e conduta em relação ao isolamento:

RT-PCR: NEGATIVO - ISOLAMENTO POR 72 HS APÓS REMISSÃO DOS SINTOMAS

POSITIVO - ISOLAMENTO POR 14 DIAS

TESTE RÁPIDO E SOROLOGIA:

COM RESULTADO DE IgM e IgG separadamente:

IgM e IgG positivos: isolamento por 14 dias
IgM positivo e IgG negativo: isolamento por 14 dias
IgM negativo e IgG positivo: caso recuperado, não indica isolamento
IgM e IgG negativos: susceptível, isolamento por 14 dias

SEM RESULTADOS DE IgM e IgG separadamente:

Teste positivo: caso ativo, isolamento por 14 dias
Teste negativo: caso susceptível, isolamento por 14 dias

ASSINTOMÁTICOS
Recomendações

Estratégia planejada e adotada pelos municípios com objetivo específico de avaliar a extensão da transmissão da doença (prevalência) em determinadas populações ou grupos:

- Trabalhadores da Saúde
- Trabalhadores da Segurança Pública
- Presídios
- Inquéritos sorológicos: normatização através da SS 80 - de 08.06.2020, presente no site do CVE-SP, onde está disponível o formulário para registro dos inquéritos soro-epidemiológicos.

RESULTADOS e conduta em relação ao isolamento:

1- COM RESULTADO de IgM e IgG separadamente:

- IgM e IgG positivos: sem necessidade de isolamento
- IgM positivo e IgG negativo: isolamento de 7 dias a partir da data da coleta
- IgM negativo e IgG positivo: caso recuperado, sem necessidade de isolamento
- IgM e IgG negativos: susceptível, sem necessidade de isolamento individual

2- SEM RESULTADOS de IgM e IgG separadamente:

POSITIVO: caso ativo, isolamento de 7 dias a partir da data da coleta
NEGATIVO: caso susceptível, sem necessidade de isolamento individual

As medidas de isolamento social devem sempre ser respeitadas, independentemente dos resultados.

Notificação:

Casos de síndrome gripal: notificar no eSUSVE (incluindo casos individuais que fazem parte de surtos).

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): notificação no SIVEP Gripe.

Surtos devem ser notificados no SINAN-Net módulo surto com CID J07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 633 – Centro – CEP 14.700-000
E-Mail: smspitangueiras@hotmail.com

IMPORTANTE

Informação sobre envio de resultados de exames realizados em laboratórios privados:

Informamos a todos que, no último dia 03/07/2020, foi publicada no Diário Oficial do município de Ribeirão Preto a Portaria Nº 71/2020, que disciplina a realização de testes para COVID-19. De acordo com esta Portaria, os laboratórios deverão notificar diretamente no eSUSVE os resultados de todos os pacientes que realizarem exames que não apresentarem solicitação médica.

Portanto, o GVE não recebe mais estes resultados por planilhas, como estava acontecendo até o momento.

Os laboratórios continuarão encaminhando os resultados de pacientes que realizaram exames com solicitação médica através de planilha e estes resultados serão enviados para a respectiva Vigilância Epidemiológica do município de residência, via e-mail.

Solicitamos que continuem acompanhando pelo eSUSVE a entrada destas notificações.

Na certeza de efetiva colaboração e apoio, agradecemos a atenção, alterações nesta deliberação serão reportadas imediatamente.

Att,

Elisabete Paganini
Diretor Técnico de Saúde II

Daniel Marques
Interlocutor de COVID-19

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SANTA CASA DE PITANGUEIRAS COVID-19

Pitangueiras, 15 de Abril de 2020.
1ª Revisão: 16 de junho de 2020.

João Rocha da Silva - Provedor
Ricardo Augusto da Silva - Gerente Administrativo
Dr. Rodolfo Aparecido da Silva - Diretor clínico
Dra. Maria Rita Margarido Chaparim - Médica Infectologista SCIH

OBJETIVO

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar a equipe da Santa Casa de Pitangueiras no enfretamento de um possível surto de coronavírus. Através deste documento, pretende-se:

- Definir o quadro atual desta doença, bem como seu método de transmissão e manifestações;
- Orientar medidas de precauções e isolamento para contenção da disseminação do vírus, especialmente em ambiente hospitalar;
- Implantar ações de assistência, vigilância e comunicação que auxiliem no uso de recursos disponíveis e oriente condutas frente ao aumento de demanda;
- Orientar quanto ao fluxo de recebimento e encaminhamento de pacientes;
- Orientar os processos de limpeza ambiental, processamento de roupas e descarte de resíduos no serviço;

DEFINIÇÃO

Os coronavírus (CoV) compõem uma grande família de vírus de RNA, conhecidos desde meados da década de 1960, que receberam esse nome devido às espículas na sua superfície, que lembram uma coroa.

Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como o surto ocorrido em 2002 pelo SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus) e o surto de 2012 no oriente médio pelo MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus).

SITUAÇÃO ATUAL

A transmissão atual, identificada em 7 de janeiro de 2020 na cidade de Wuhan,

China, corresponde a uma nova variante do coronavirus, denominado SARS-CoV-2. A doença causada pelo SARS-CoV-2 ficou denominada como COVID-19 (Coronavirus disease-19).

Sua origem ainda não está elucidada, porém acredita-se que a fonte primária seja em um mercado de frutos do mar e animais vivos em Wuhan, sugerindo uma disseminação de animais para pessoas.

Em 22 de janeiro de 2020 o Brasil ativou o Comitê de Operações de Emergência (COE-nCov) para coordenar a preparação de resposta adequada, ordenada e integrada frente a uma possível emergência nacional.

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Essa decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus.

Em 31 de janeiro é acionado o Grupo Executivo Interministerial (GEI-ESP) e 3 de fevereiro o Brasil declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Em 25 de fevereiro de 2020 o Brasil confirmou o primeiro caso de COVID-19 no país.

Em 11 de março de 2020 a OMS classificou a doença como Pandemia e em 20 de março de 2020 foi declarada transmissão comunitária em todo o território nacional. Os casos confirmados no país se concentram no estado de São Paulo e em cidades mais populosas, porém já se confirmaram casos em diversas cidades do interior.

Em 20/03/2020 foi declarado por meio da portaria Nº 454, estado de transmissão comunitária em todo o território nacional.

TRANSMISSÃO

Após um número crescente de pacientes sem exposição a este mercado de frutos do mar, acredita-se que a transmissão esteja ocorrendo de pessoa para pessoa, como já observado previamente em outros coronavírus. Acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas na tosse/espirro, tendo sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas.

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus, nem quanto tempo após a doença ela permanece eliminando agentes infectantes.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 14 dias.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O espectro clínico varia desde um resfriado até uma pneumonia grave. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dispneia.

Em avaliação de 99 pacientes com pneumonia e diagnóstico laboratorial de COVID-19 internados no hospital de Wuhan, aponta-se maior taxa de hospitalização em maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais sintomas foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorreia (4%), dor no peito (2%), diarreia (2%) e náusea e vômito (1%). Segundo exames de imagem, 74 pacientes (75%) apresentaram pneumonia bilateral, 14 pacientes (14%) apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente (1%) evoluiu com pneumotórax. Complicações observadas até o momento incluem síndrome respiratória aguda grave - SRAG (29%), lesão cardíaca aguda (12%) e infecção secundária (10%).

DEFINIÇÃO DE CASOS

CASOS SUSPEITOS:

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre*, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.

*Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente.

1. EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
2. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

1. EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

CASOS CONFIRMADOS:

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:

- Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, Influenza ou VSR):
  - Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.
  - Influenza: com resultado detectável para Influenza.
  - Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.
- Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):
  - Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

CASO DESCARTADO:

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES

● FEBRE:

- Considera-se febre temperatura acima de 37,8°

- Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

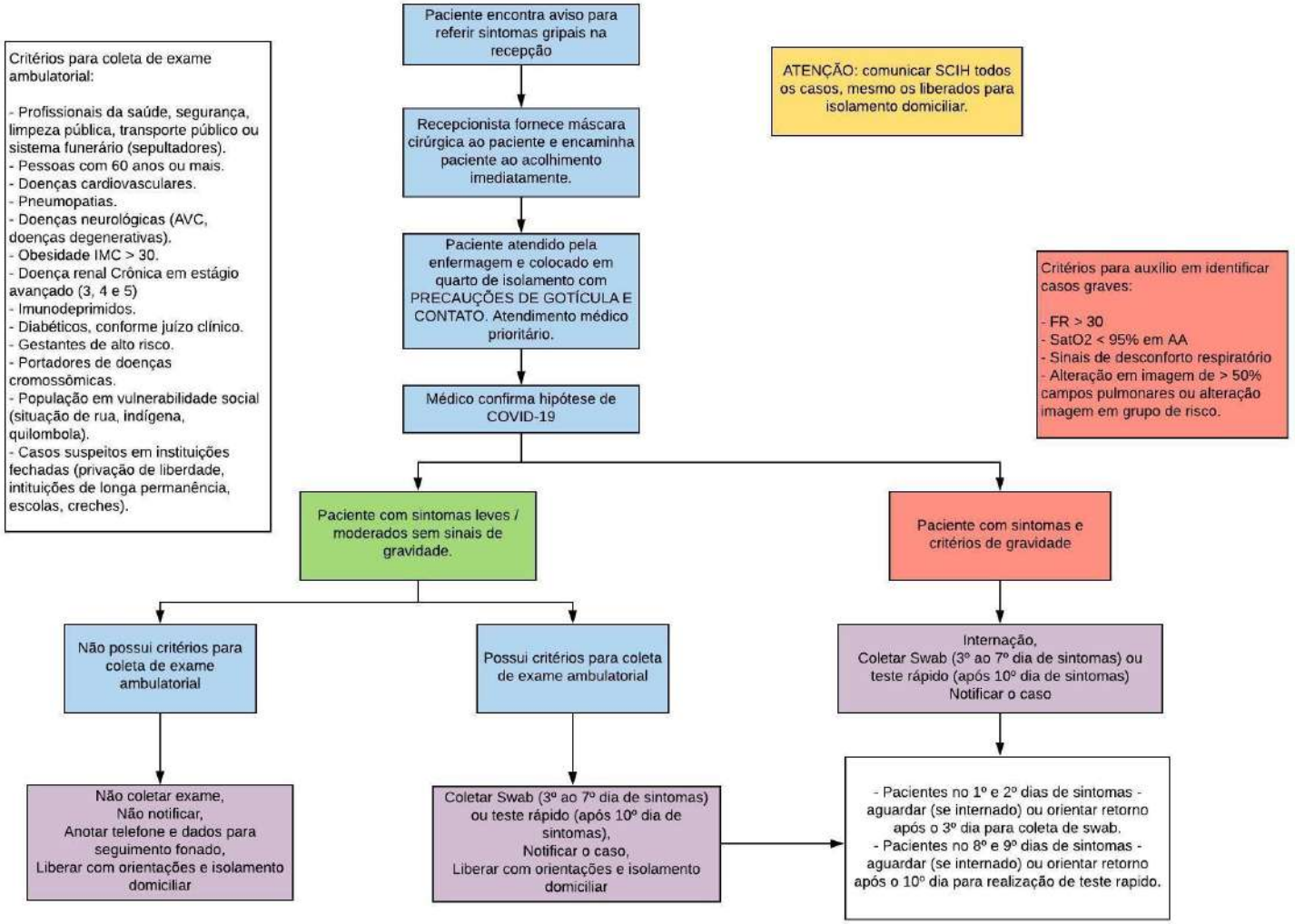
- Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada

● CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19

- Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se o ambiente e o tempo de exposição

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NA SANTA CASA DE PITANGUEIRAS – COVID – 19



OBS: diante de caso suspeito, a enfermagem do acolhimento e o médico que irá realizar a avaliação devem estar paramentados com avental cirúrgico ou descartável, luvas de procedimento, gorro descartável, óculos de proteção, máscara cirúrgica OU máscara N95 e protetor facial. Seguir orientações de isolamento de contato + gotículas.

Foi proposta mudança do funcionamento do pronto atendimento para separação do atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios e pacientes com outras queixas agudas (2 médicos diferentes, equipe fixa separada e separação física), ainda em análise de possibilidade (de acordo com recursos financeiros e reforma do local).

RECEPÇÃO

Quando o paciente chegar a recepção da Santa Casa, independentemente de seu convênio a recepcionista deverá perguntar ao mesmo se ele está com sintomas gripais como: FEBRE, TOSSE, DISPNÉIA, DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, DOR DE GARGANTA, se o paciente apresentar qualquer um destes sintomas, deverá ser imediatamente fornecida a máscara para o mesmo, em seguida feito a ficha de atendimento e IMEDIATAMENTE ligar ao acolhimento e informar a enfermeira do plantão qual o nome do paciente e que ele é um possível caso suspeito de 30coronavírus.

As recepcionistas deverão usar os seguintes EPIs: mascaras, roupas sem decotes, sapatos fechados, e higienizar as mãos com maior frequência se possível com água e sabão, não havendo a possibilidade de lavar as mãos, deverão utilizar álcool 70%.

Os teclados e mouses deverão ser higienizados diariamente no mínimo 3 x ao dia, com LETHA OXI CD, que estarão disponíveis no setores, lembrando que os teclados estarão cobertos com plástico filme, o que facilita a higienização dos mesmos.

ACOLHIMENTO

Assim que a recepcionista comunicar a enfermeira do acolhimento sobre o paciente com sintomas gripais a mesma deverá confirmar se o paciente está fazendo uso da máscara descartável, e encaminhar imediatamente o paciente para o quarto de isolamento, onde o mesmo aguardará atendimento médico sentado. Este procedimento vale apenas para pacientes que apresentarem sintomas leves: FEBRE, TOSSE, DOR DE GARGANTA.

Se o paciente apresentar os seguintes sintomas: FEBRE, TOSSE, DOR DE

GARGANTA, DISPNÉIA, ESFORÇO RESPIRATÓRIO o mesmo deverá ser encaminhando imediatamente para sala de estabilização e acomodado ao leito, ser monitorizado (oximetria de pulso) e verificado sinais vitais, imediatamente após monitorização a enfermeira deverá comunicar o caso ao médico do plantão.

A enfermeira do acolhimento deverá usar os seguintes EPIs: Camisetas sem decotes branca, calça jeans branca, sapato fechado branco, avental de tecido cirúrgico, avental descartável, touca descartável, luvas de procedimento, máscara N95 e protetor facial.

A máscara N95 deverá ser utilizada OBRIGATORIAMENTE em conjunto com protetor facial, desta maneira poderá ser reutilizada por 15 dias, desde que seja respeitado o manuseio e armazenamento correto.

O protetor facial deverá ser higienizado sempre que necessário e obrigatoriamente nas trocas de plantões.

Nos casos em que o paciente chega a unidade de ambulância o mesmo já será acomodado na Sala de Estabilização, a recepção deverá acionar a enfermeira do acolhimento imediatamente, e após a avaliação da enfermeira a mesma solicitará a avaliação médica deste paciente.

ISOLAMENTO NO PRONTO SOCORRO

Pacientes classificados como suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao quarto de isolamento, bem como em qualquer ocasião em que haja necessidade de transportá-lo entre setores. Mantê-los em quarto privativo.

Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão (higiene das mãos antes e após todo tipo de contato), precaução de contato (luvas, avental não estéril e óculos de proteção) e precaução respiratória para gotículas (máscara cirúrgica). Visto que a transmissão se dá por contato e gotículas, acompanhantes podem fazer uso de máscara cirúrgica para precaução. Devido à ausência de informações sobre duração da excreção viral do novo Coronavírus, o paciente permanecerá em precaução específica até sua alta hospitalar.

MANEJO DE CASOS LEVES

Após avaliação médica se o paciente estiver apresentando sintomas leves, será

medicado se necessário e orientado pela enfermagem quanto ao ISOLAMENTO DOMICILIAR (entregar para o paciente informações – Folder informativo), e a observar seus sintomas, caso haja alguma piora em seu quadro (FEBRE, TOSSE, DOR DE GARGANTA, DISPNÉIA, ESFORÇO RESPIRATÓRIO) deverá procurar imediatamente a Santa Casa. O médico responsável pelo atendimento de paciente que irá ser liberado deve preencher o termo de declaração de isolamento domiciliar, enumerando nome do paciente e contatos domiciliares (**ANEXO 1**), e realizar atestado médico para 14 dias de afastamento.

Em casos que não se encaixam nos critérios de coleta exames diagnósticos de forma ambulatorial, não coletar amostra para exame de PCR ou Teste Rápido e não notificar casos leves, conforme orientação do governo estadual de São Paulo. Em casos que se encaixem nos critérios, coletar exame conforme dia do início dos sintomas e notificar o caso.

Todos os pacientes liberados para isolamento domiciliar devem ser anotados em documento próprio disponibilizado para a enfermagem do pronto atendimento, com o devido contato telefônico, para seguimento a cada 48h a fim de verificar a evolução do paciente.

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR

- Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas;
- Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;
- Usar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e sempre higienizar as mãos após;
- Evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas, toalhas;
- Manter os ambientes bem ventilados

MANEJO CASOS MODERADOS / GRAVES

Se o paciente for acomodado na Sala de Estabilização (ISOLAMENTO PARA CASOS MODERADOS), após avaliação médica, lembrando que neste momento este

profissional também já deverá estar adequadamente paramentado com seus EPIs, serão realizadas medicações conforme prescrição médica e provavelmente solicitada vaga via Central de Vagas, pois possivelmente este paciente poderá evoluir para um quadro respiratório grave necessitando de um leito de UTI.

Critérios para SRAG e auxílio na decisão de gravidade:

- Sinais de desconforto respiratório,
- Frequência respiratória > 30 irpm,
- SatO2 ar ambiente < 95%.

Se for necessária a internação deste paciente a enfermagem orientará os seus familiares a procurarem a recepção para realização deste procedimento, vide (**MANEJO DE PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA E/OU COVID 19).**

Coleta de amostra para pesquisa de coronavírus para casos internados com SRAG (PCR ou Teste rápido, a depender da data de início dos sintomas). Notificar casos internados.

Em relação a solicitação de vagas, nos casos em que os paciente não tem convênio e forem SUS, a solicitação de vagas ocorrerá pela Central de Regulação CROSS, a solicitação deverá ser feita na FICHA SÍNDROME GRIPAL, nossa referência será em casos de internação clínica adulto e infantil, e internação UTI adulto a Santa Casa de Jaboticabal e UTI infantil será no HC Ribeirão Preto, porém quem definirá o local para ser encaminhado os pacientes será o médico regulador da CROSS, fluxo esse que foi definido pela DRS de Ribeirão Preto a qual a Santa Casa (Horizonte Verde) faz parte.

Pacientes que tem convênio médico a recepcionista entrará em contanto com a central reguladora de cada convênio, em seguida o médico do plantão passará o caso clínico de seu paciente e solicitará vaga em outras instituições com os recursos necessários. Conforme informado por responsável pelos convênios, os hospitais de referência serão: plano Unimed – Hospital Unimed Ribeirão Preto; plano Sermed – Santa Casa de Sertãozinho.

Caso este paciente evolua com quadro respiratório grave imediatamente deverá ser conduzido a Sala de Urgência, neste momento será acompanhado pelo médico responsável e por um enfermeiro, lembrando que deverão permanecer na Sala somente os funcionários necessários para realizar assistência adequada, é importante neste momento que se possível reduzir a quantidade de funcionários que terão contato com

este paciente, evitando a disseminação do vírus.

Os profissionais que estiverem na Sala de Urgência deverão usar os seguintes EPIs: máscara N95, protetor facial, luvas de procedimento, touca descartável e avental descartável, ficarão disponíveis na Sala de Estabilização KITs com EPIs para os funcionários, assim como já foi solicitada confecção de uniformes de uso restrito do Pronto Socorro, os funcionários foram orientados a colocarem está roupa antes de assumir o plantão, e depois colocarem seus EPIs, ao término do plantão deixar o uniforme na Lavanderia para serem higienizados e depois utilizado novamente no dia seguinte.

Estarão disponíveis também KITs para verificação de Sinais Vitais dos pacientes que chegarem ao PS com suspeita de COVID 19, assim como caixas exclusivas para acondicionamento de materiais utilizados durante sua assistência, depois estas caixas serão encaminhadas a Central de Materiais Esterilizados – CME para higienização, ao chegar no CME o funcionário do setor já estará utilizando seus EPIs (Avental impermeável, gorro descartável, luva de látex de cano longo, óculos de proteção, e máscara cirúrgica descartável) estes materiais serão lavados conforme a rotina do setor, com auxílio da lavadora ultrassônica e detergente enzimático ou permaneceram na solução de hipoclorito, após serão enxaguados em água filtrada e corrente, realizada secagem com ar comprimido ou compressa embebidas em álcool 70%, embaladas em papel grau cirúrgico, campo estéril ou papel pardo e por fim auto clavadas.

Caso seja solicitada coleta de exames pelo médico responsável, o enfermeiro que estiver na Sala de Urgência deverá fazer a coleta destes exames, pois já estará devidamente paramentado, foi estabelecido com o responsável do laboratório Dr. Pacca os exames que serão necessários ser coletados para os casos suspeitos de coronavírus, que são: HEMOGRAMA, PCR QUANTATIVO, TGO, TGP, ALBUMINA, LDH (DESIDROGENASE LÁCTICA), VHS, BILIRRUBINAS, CREATININA. O laboratório deixará na Sala de Urgência um KIT PARA COLETA DE EXAMES - COVID 19 (com 1 tubo roxo, 1 tubo vermelho, 1 tubo preto, seringas e agulhas), a solicitação/requisição de exames ficará pronta no Posto de Enfermagem do Pronto Socorro, a mesma de conter a assinatura do médico e etiqueta do paciente.

Segundo informações de responsável pelo laboratório estes exames serão feitos com caráter de URGÊNCIA e ficaram prontos em média em uma hora ou antes.

Se for necessário que o profissional que estiver na Sala de Urgência saia, o

mesmo deverá retirar todos os EPIs adequadamente evitando tocar nas superfícies possivelmente contaminadas, realizar a higiene adequada das mãos com água e sabão.

Se for solicitado exame de raio-X, o profissional do setor de radiologia será acionado, o mesmo deverá estar utilizando todos seus EPIs (máscara N95, avental descartável, protetor facial, luvas de procedimento) temos uma aparelho de raio x portátil que ficará armazenado na sala de estabilização, após ser realizado o exame do paciente o aparelho será higienizado com LETHA OXI CD pela funcionária do setor e novamente acondicionado na sala de estabilização.

MANEJO DE VIA AÉREA

A recomendação atual é de intubação orotraqueal precoce em casos de insuficiência respiratória grave, não sendo indicada realização de ventilação não invasiva com pressão positiva, devido à grande possibilidade de disseminação do vírus nestas condições.

Ficam também suspensos procedimentos de aerossol (salbutamol, ipratrópio, etc) conforme orientação da SMS Pitangueiras. Foram adquiridas medicações em spray com espaçador para casos de broncoespasmo.

Para manejo da via aérea é necessária paramentação completa, com avental de mangas longas, gorro, máscara tipo N95/PFF2, protetor facial ou óculos de proteção e luvas para todas as pessoas no ambiente. Restringir a equipe a um médico e um enfermeiro dentro da sala onde será feito o procedimento. De preferência convocar o médico mais experiente para manejar a via aérea.

Realizar pré-medicação, idealmente com:

- Lidocaína 2% sem vasoconstritor (1,5mg/kg) 3 minutos antes da indução MAIS
- Cetamina (1,5 a 2 mg/kg) MAIS
- Succinilcolina (1,5 mg/kg).

Segundas opções:

- Etomidato (0,3 mg/kg) OU
- Midazolam (0,5-1,5 mg/kg) MAIS
- Fentanil (1-2,5 mg/kg) MAIS
- Succinilcolina (1,5 mg/kg).

Na pré-oxigenação não realizar ventilação assistida com bolsa-valva-máscara, apenas fornecer oxigênio sem pressão positiva.

Clampar o tubo com pinça reta forte ou com êmbolo de seringa e proceder intubação. Acoplar ao ventilar para testar posicionamento do tubo, sem realizar ventilação com AMBU. Caso seja necessário desconexão do sistema clampar novamente o tubo com pinça reta forte.

Não realizar aspiração de vias aéreas em sistema aberto, apenas com sistema fechado.

Utilizar ventilador mecânico com filtro HEPA e filtro bacteriológico e higienizar imediatamente após o término do uso pelo paciente.

MANEJO DE PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA E/OU COVID 19

O paciente com suspeita e/ou com COVID 19 que necessitará de internação será proveniente do Pronto Socorro, este já estará em uso de máscara cirúrgica descartável e será acomodado em leito de isolamento previamente definido pela CCIH desta instituição, vide **ANEXO 2 – DIVISÃO DE LEITOS PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID 19.** Em caso de aumento de demanda, os pacientes serão alocados em quartos de não isolamento, sozinhos, com precauções de contato e gotículas. Pacientes confirmados por meio de exames diagnósticos poderão ser colocados em isolamento de coorte, no mesmo quarto. Não serão acomodados em isolamento de coorte pacientes confirmados com suspeitos ou pacientes suspeitos entre si.

Este paciente será isolado em **PRECAUÇÃO PARA CONTATO E GOTÍCULAS**, no posto de enfermagem da Clínica Médica estão disponíveis placas de identificação que deverão ser colocadas na porta do quarto deste paciente para a devida sinalização.

Deverá ser utilizado os seguintes EPIs pela equipe de enfermagem: máscara cirúrgica, protetor ocular, luvas de procedimento e avental cirúrgico e máscara N95 para realização de procedimentos com risco de aerossolização.

Este paciente não poderá receber visitas a título de prevenção para disseminação do vírus, poderá ter acompanhante se for necessário, respeitando as normas internas da instituição que são: menores de 18 anos, acima de 60 anos, gestantes e pacientes com alguma deficiência física ou mental.

A equipe de enfermagem realizará um rodizio dos profissionais que irão prestar assistência a este paciente, dessa forma diminuirá as chances de disseminação da doença, este rodizio será estabelecido pela enfermeira responsável do plantão, que avaliará o perfil de cada profissional e/ou suas limitações/fatores de risco.

Os EPIs deverão ser utilizados pelo funcionário que ficará responsável pelo paciente sempre que o mesmo for entrar em contato com ele.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Devem utilizar os EPI (máscara cirúrgica, protetor ocular, luvas de procedimento e avental):

- A partir de orientação da resolução SS-28 do diário oficial do Estado de São Paulo, recomenda-se uso de EPI a todos os funcionários envolvidos no atendimento, sobretudo aqueles em contato direto com os pacientes. Deve-se incluir profissionais da recepção, limpeza, manutenção, segurança, entre outros.
- Profissionais que não irão lidar diretamente a menos de 1 metro com pacientes pode utilizar somente máscara.
- Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito ou entrar no isolamento.
- Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol em atendimento a pacientes com suspeita ou confirmados para infecção pelo coronavírus deve utilizar luvas de procedimento, avental e protetor ocular, além da máscara de proteção respiratória (máscara tipo respirador - N95).
- Todos os profissionais de saúde que prestam assistência direta ao paciente e profissional designado para a triagem de casos suspeitos.
- Toda a equipe de suporte, que tenha contato a uma distância menor que 1 metro de pacientes suspeitos ou confirmados, incluindo pessoal de limpeza, nutrição e responsáveis pela retirada de roupas sujas da unidade de isolamento. Recomenda-se que o mínimo de pessoas entre no quarto do paciente suspeito ou confirmado.
- Todos os profissionais de laboratório, durante coleta, transporte e manipulação de amostras de pacientes suspeitos e confirmados; deve-se utilizar máscara N95 quando coleta espécime clínico para diagnostico etiológico (secreções respiratórias).
- A máscara cirúrgica deve ser descartada após uso, trocada assim que estiver suja ou úmida. Não reutilizar máscaras cirúrgicas.
- A máscara tipo respirador particulado (N95, PFF2 ou 3) pode ser utilizada por 15 dias

se estiver íntegra (fonte: orientações SBPT), limpa e seca, pelo mesmo profissional, desde que retirada e usada corretamente (retirar pelos elásticos e acondicionar em saco ou envelope de papel com os elásticos para fora) e com uso concomitante de protetor facial (face shield).

ATENÇÃO: O uso de máscaras caseiras NÃO garante proteção ao profissional de saúde visto não estarem registadas na ANVISA como material testado para efeito filtração de partículas e gotículas.

COLOCAÇÃO DE EPI:

- Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel (seguir POP de higienização das mãos).
- Colocar primeiro o avental, amarrando sempre as faixar superiores e na cintura.
- Em seguida colocar a máscara.
- Colocar os óculos.
- Colocar o gorro.
- Higienizar as mãos.
- Calçar luvas.

RETIRADA DE EPI:

- Retirar as luvas; retirar a primeira luva tocando na superfície externa com a outra mão enluvada, retirar a segunda luva pegando pela parte interna com a outra mão desenluvada.
- Retirar o avental cuidando para não tocar a parte externa.
- Higienizar as mãos.
- Retirar o gorro pegando pela parte de trás.
- Retirar óculos ou protetor pelas hastes, não tocar a parte frontal.
- Higienizar as mãos.
- Retirar a máscara cirúrgica pegando nas tiras, sem encostar na parte frontal.

Para casos em precaução de aerossol, seguir os mesmos passos acima, com as seguintes alterações:

- Retirar máscara N95/PFF2 pelos elásticos em tocar a parte interna.

- Devido à escassez de EPI, fica autorizada a reutilização de máscara N95/PFF2 desde que em uso concomitante do protetor facial, verificada sua integridade e funcionalidade (fazer teste de vedação e inspeção visual). Retirar a máscara sem tocar a parte interna, pelos elásticos, acondicionar em saco plástico não hermético aberto. Em caso de contaminação ou não funcionamento adequado, descartar a máscara.
- A máscara poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional (uso individual) por até 15 dias, desde que realizados os passos dos itens anteriores.

ATENÇÃO: descartar EPIs em lixo infectante branco. Higienizar EPI reutilizáveis (óculos e protetor facial) com álcool 70% após cada uso.

RECOMENDAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- Máscara: evitar tocar a máscara com frequência durante seu uso, trocá-la sempre que suja ou molhada, não tocar a parte interna da máscara N95; a máscara N95 pode ser reutilizada enquanto permanecer limpa e seca, por um período máximo de 15 dias, devendo ser sempre adequadamente acondicionada em saco plástico protetor SEMPRE utilizada com protetor facial.
- Luvas: as luvas NÃO SUBSTITUEM a higienização das mãos; trocá-las sempre que for trocar de paciente; não lavar luvas
- Avental descartável: sempre usar durante o atendimento e deixar pendurado em descartar logo após sair da área de atendimento do paciente; não reutilizar entre pacientes; em caso de sujidade que atravesse o avental, trocar de roupa privativa para um conjunto limpo;
- Óculos de proteção / Protetor facial: após cada uso, realizar desinfecção com álcool 70%, podendo ser reutilizado por outros profissionais após esse procedimento;
- Higienização das mãos: segue sendo a principal medida de prevenção de transmissão de infecções em ambiente hospitalar, portanto deve ser SEMPRE realizada antes e após qualquer contato com o paciente e o ambiente ao seu redor.

MANEJO DE PACIENTES QUE EVOLUIREM Á ÓBITO

- Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os profissionais estritamente necessários, utilizando os seguintes EPIs - máscara N95, protetor facial, luvas de procedimento, touca descartável e avental descartável.
- Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.
- Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável, como já fazemos de rotina colocar sobre os orifícios gaze ou algodão e cobrir com esparadrapo.
- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas se necessário e logo após descartar no resíduo com saco BRANCO/LEITOSO.
- Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais, colocar gaze/algodão ou se for necessário compressas pequenas e passar esparadrapo em cima para garantir que não saiam quando o cadáver for movido.
- Descartar imediatamente os resíduos perfuro cortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante, em seguida descartar esse recipiente todo independentemente da quantidade de resíduo que ele contenha.
- Acondicionar o corpo em saco impermeável fechado.
- Identificar adequadamente o cadáver com uma folha -" este paciente era suspeita OU caso confirmado de coronavírus".
- A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e desinfeção, após o transporte do cadáver até o Necrotério deixar a maca na área externa para que a equipe de limpeza realize a higienização.

- Após remover os EPIs de forma adequada, evitar encostar nas áreas frontais dos EPIs, pois essas regiões estavam em contato com secreções ou sangue do paciente, após sempre proceder à higienização das mãos.
- O hospital deve avisar o serviço funerário que se trata de um caso suspeito ou confirmado de covid-19 para que as precauções sejam tomadas pela funerária.

ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DO PACIENTE

Após paciente ser estabilizado e vaga ser cedida pela central de regulação, o enfermeiro responsável pelo plantão deverá providenciar o transporte para o encaminhamento deste paciente para outra instituição. Os dados do paciente deverão ser inseridos na central de ambulância, o tipo de transporte deverá ser definido de acordo com o quadro clínico do paciente (Ambulância tipo A, SAMU, USA).

Caso o transporte solicitado seja USA, colocar primeiro as informações do paciente no sistema da central de ambulância e logo após fazer contato via fone, para que o médico responsável pelo paciente passe o caso para o médico da USA.

- O paciente deve usar máscara cirúrgica durante todo o transporte, desde o momento em que for identificado até a chegada ao isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível;
- Qualquer pessoa, inclusive os profissionais de saúde que entrarem em contato e manipularem o paciente suspeito ou confirmado deve utilizar EPI (máscara cirúrgica, protetor ocular, luvas e avental);

DIAGNÓSTICO

MATERIAL DE VIA AÉREA

Deve ser realizada **entre o 3º e 7º dia de sintomas** (conforme orientação do Ministério da Saúde e SMS Pitangueiras).

Está recomendado coleta de material somente para pacientes internados em estado grave, e pacientes que se encaixem nas definições de critérios para coleta ambulatorial:

- Profissionais da Saúde
- Profissionais da Segurança

- Profissionais da Limpeza Pública
- Profissionais dos Transportes Públicos
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada);
- Pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC);
- Imunodeprimidos;
- Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Doenças neurológicas (AVC, doenças degenerativas);
- Obesidade (IMC > 30).
- Diabéticos, conforme juízo clínico;
- Portadores de doenças cromossômicas (ex síndrome de Down);
- Gestantes de alto risco.
- População em vulnerabilidade social (situação de rua, indígenas, quilombolas)
- Casos suspeitos em instituições fechadas (privados de liberdade, Instituições de longa permanência, escolas, creches).

Comunicar todos os casos ao SCIH do hospital.

COLETA:

- Swab Combinado (nasal/oral): 3 Swabs de rayon de haste flexível (narina direita + narina esquerda + orofaringe). *Colocar em um único tubo de rosca estéril tipo Falcon (tampa azul) contendo 3ml de soro fisiológico estéril.

OU

- Aspirado de nasofaringe (Coletor McGrif)

OU

- Escarro, lavado traqueal ou lavado broncoalveolar ("Bronquinho")

↓

ARMAZENAMENTO:

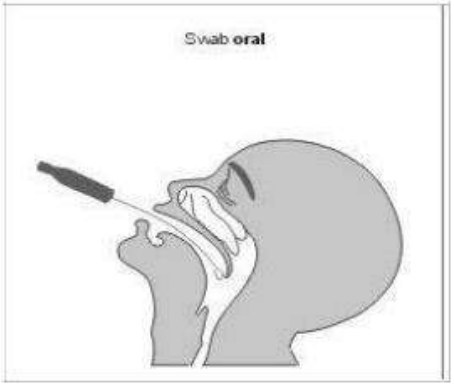
Refrigerado de 4 a 8ºC até 72 horas ou se não for possível, poderão ser congelados em temperaturas abaixo de (-) 70ºC.

ATENÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA TIPO RESPIRADOR (N95) PARA COLETA DE AMOSTRA DEVIDO RISCO DE AEROSSOLIZAÇÃO, ALÉM DOS OUTROS EPI MENCIONADOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL DESCARTÁVEL, GORRO

DESCARTÁVEL, PROTETOR FACIAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO).

- Swab: Introduzir o swab pela narina até a nasofaringe realizar movimentos rotatórios para captação de células da nasofaringe, e absorção da secreção respiratória. Realizar o mesmo procedimento em ambas as narinas; O terceiro swab será utilizado na coleta de secreção respiratória da parte posterior da orofaringe evitando contato com a língua para minimizar contaminação;





Após a coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco tipo falcon contendo 3 (três) ml de solução fisiológica 0,9%.

Certificar-se de que no local da coleta do material haverá descartes apropriados, água e sabão para a lavagem das mãos, regra básica para o controle de infecção, seguindo as boas práticas laboratoriais para coleta de material potencialmente infectante.

- Aspirado traqueal, lavado brônquio alveolar: coletar 2-5 mL em frasco estéril com tampa, ou copo para coleta de escarro estéril

- Escarro: o paciente deve lavar a boca com água e então tossir forte e expectorar diretamente no copo coletor estéril

A notificação deverá ser preenchida logo após a coleta do material, atualmente temos duas fichas disponíveis, sendo uma para pacientes internados e outra para pacientes ambulatoriais, todos os campos da notificação deverão ser preenchidos, exceto as informações relacionadas a exames sem laudos.

A solicitação do exame deverá conter etiqueta do paciente, assinatura e carimbo do médico solicitante, em seguida os swabs devem ser encaminhados ao laboratório Dr. Pacca, e posteriormente a Vigilância Epidemiológica encaminhará as amostras ao

Instituto Adolfo Lutz que é nossa referência para realização do exame para diagnóstico do COVID 19, tanto em casos de pacientes conveniados ou não.

Conforme orientado por responsável pelos convênios Unimed e Sermed, o exame de PCR viral em caso de encaminhamento do paciente a outros hospitais será realizado no hospital de referência. Somente são realizados exames em pacientes internados. O hospital deverá entrar em contato com auditor do convênio para autorização da realização do exame.

O laboratório credenciado pela Sermed é o laboratório Pardini. A Unimed orienta encaminhar o paciente a Ribeirão Preto para coleta do exame. Casos leves que irão ser liberados sem internação não serão coletados exames para pesquisa de PCR coronavírus conforme informe dos convênios.

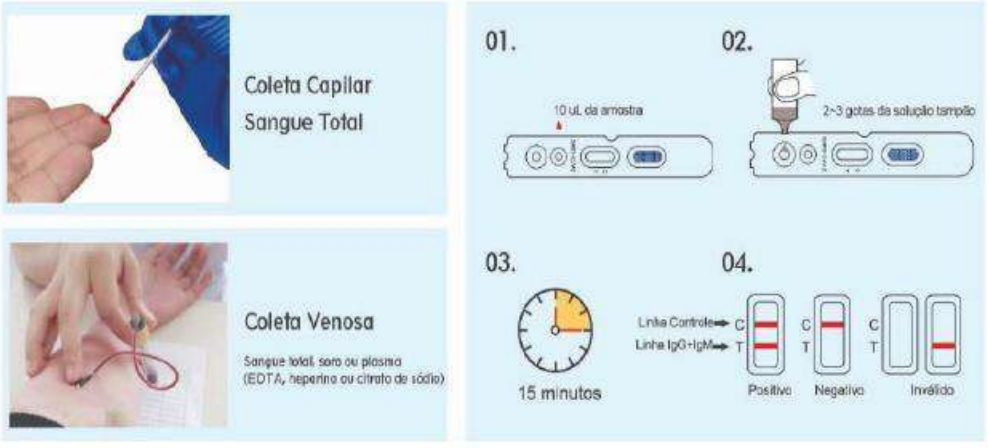
TESTE RÁPIDO

Os testes rápidos disponibilizados pelo ministério da saúde são destinados a populações específicas, apresentando-se sintomáticos.
Indicações:
1. Profissionais de saúde em atividade;
2. Profissionais de segurança pública em atividade;
3. Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade.
4. Pacientes com critérios de risco, mesmos critérios acima (material de nasofaringe).

O teste rápido deve ser realizado **após o 10º dia de sintomas**.

Os convênios não fornecem realização de testes rápidos.

A coleta de sangue deve ser feita por meio de punção digital ou venosa, seguindo instruções contidas no kit do teste rápido para sua realização. O material preferível e aconselhado para realização é sempre o plasma, devido maior sensibilidade deste material.



A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior, na Secretaria Municipal de Saúde.

Condições para realização:

- Profissionais de saúde e segurança pública: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal* E mínimo de 72 horas assintomático**;
- Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal.

* A definição de Síndrome Gripal é: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por febre ou sensação febril, acompanhada de tosse E/OU dor de garganta E/OU coriza E/OU dificuldade respiratória.

** A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste,
se deve a evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.

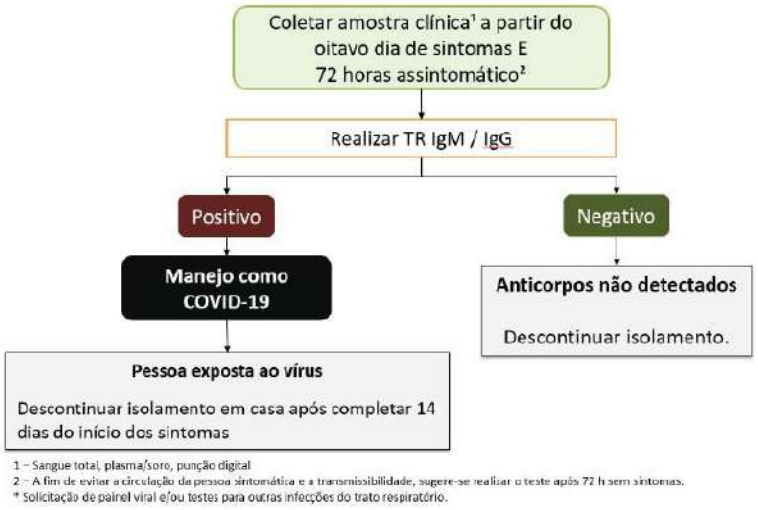
Interpretação dos resultados:

- Em caso de profissional sintomático:

- Negativo: os profissionais de saúde e segurança ficam aptos a retornar imediatamente ao trabalho, utilizando máscara cirúrgica até o final do período de 14 dias.
- Positivo: determina afastamento de 14 dias, após o início dos sintomas.

- Em caso de profissional contactante domiciliar de caso suspeito: realizar o teste rápido na pessoa sintomática que mora no domicílio do profissional de saúde ou segurança.

- Negativo: os profissionais de saúde e segurança contactantes ficam aptos a retornar imediatamente ao trabalho, utilizando máscara cirúrgica até o final do período de 14 dias.
- Positivo: determina manutenção do afastamento de 14 dias, após o início dos sintomas do paciente que reside no domicílio do profissional contactante.



Exemplo de aplicação do teste:

Numa situação hipotética, um trabalhador iniciou os sintomas em 01/03. O médico orientou que fique em isolamento até o dia 15/03. Em 06/03, no isolamento domiciliar, os sintomas desapareceram. Em 09/03, poderá ser realizado o teste rápido sorológico. De acordo com o resultado, será adotada uma das seguintes condutas:

- **- Resultado positivo: manter o isolamento até o dia 15/03.**
- **- Resultado negativo: retorna ao trabalho e utiliza máscara cirúrgica até o dia 15/03.**

- Em caso de paciente com SG ou SRAG com critérios de coleta:

- Positivo: em caso de paciente com quadro clínico e tempo de sintomas compatível, considerar caso positivo para COVID-19.

- Negativo: avaliar data de início de sinais e sintomas. Caso persistir a suspeita, não descartar caso de COVID-19 somente por resultado do teste rápido.

- Notificação:

É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes rápidos e notificação para a VE municipal destes resultados.

Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso o resultado positivo ou negativo. Essas informações são essenciais para monitoramento da epidemia no Brasil.

TRATAMENTO

CASOS GRAVES:

Até o momento, não há um medicamento específico para tratamento do COVID-19, nem evidências de eficácia do uso de antivirais já conhecidos.

Em estudo recente de Oxford (RECOVERY) foi encontrado benefício no uso de Dexametasona 6mg/dia para pacientes em uso de oxigênio ou ventilação mecânica, por 10 dias.

Em casos de sepse, seguir protocolo de sepse para guiar o tratamento antimicrobiano associado ao manejo clínico de complicações do COVID-19.

Em 26/03/2020 foi liberado pela ANVISA a cloroquina / hidroxicloroquina para uso em pacientes com quadros graves de COVID-19. Porém, não há evidência científicas que suportem o uso do medicamento, ficando a prescrição a critério do médico responsável pelo paciente. O uso preconizado é de 5 dias, com doses:

- Difosfato de Cloroquina:

  D1: 500mg 12/12h (comprimido de 250mg) ou 450mg 12/12h (comprimido de 150mg)

  D2 ao D5: 500 mg 24/24h (comprimido de 250mg) ou 450 mg 24/24h (comprimido de 150mg)

- Sulfato de Hidroxicloroquina:

  D1: 400mg 12/12h

  D2 ao D5: 400mg 24/24h

ATENÇÃO: em todos os pacientes, realizar ECG 12 derivações antes de iniciar uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, avaliar intervalo QT – a medicação pode aumentar o intervalo QT gerando arritmias graves (torsade de pointes). Repetir ECG diariamente enquanto em uso da medicação, principalmente em caso de uso concomitante de outras medicações que aumentem o intervalo QT (checar lista abaixo).

Pode ser associado uso de azitromicina 500mg por 5 dias a depender de avaliação médica – ATENÇÃO ao uso concomitante de cloroquina com azitromicina, pois a azitromicina também aumenta o intervalo QT (seguir recomendação acima).

Em pacientes críticos deve ser realizado profilaxia de tromboses, com heparina não fracionada na dose de 5.000 UI 12/12h ou 8/8h (se risco de trombose elevado). Realizar heparina somente se plaquetas > 70.000.

Em casos graves e pacientes com comorbidades (cardiopatia exceto HAS, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos,

imunossupressão, neoplasias, HIV/AIDS, doenças neuromusculares, obesidade, tuberculose, pneumopatias), idosos > 60 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso, crianças < 5 anos, menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico) deve ser associado uso de Oseltamivir por 5 dias para tratamento de Influenza, pois esta patologia é de difícil diagnóstico diferencial com COVID-19 (o uso de Oseltamivir não trata a COVID-19).

- Oseltamivir:

  - 1 comprimido de 75mg a cada 12 horas por 5 dias.

O uso concomitante de antibióticos está sujeito a avaliação médica conforme protocolo de manejo de PAC ou pneumonia hospitalar, a depender da situação.

CASOS LEVES:

Em diretriz publicada em 18 de maio de 2020 pelas Sociedades Brasileiras de Infectologia, Pneumologia e Tisiologia e pela AMIB, não é indicado o uso rotineiro de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, corticóides e Kaletra para o tratamento da doença. A Dexametasona não deve ser utilizada em pacientes sem necessidade de oxigênio.

Apesar disso, o Ministério da Saúde lançou novo protocolo de tratamento da COVID-19 em 20 de maio de 2020 no qual indica o uso da cloroquina / hidroxicloroquina em casos leves e moderados, ressaltando que não há evidência de funcionamento da medicação e com a necessidade da discussão médico-paciente e mediante assinatura de termo de consentimento (**ANEXO 3**) pelo paciente, e sob responsabilidade do médico prescritor. A posologia das medicações é a mesma contida acima, em pacientes graves.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- São contra-indicações absolutas ao uso da Hidroxicloroquina: gravidez, retinopatia/maculopatia secundária ao uso do fármaco já diagnosticada, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia grave.
- Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há interação moderada da hidroxicloroquina com: digoxina (monitorar), ivabradina e propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 220 mg para 110 mg),

edoxabana (reduzir dose de 60 mg para 30 mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina.

- Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, estreptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos.
- Deve ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais.
- A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a realização de Eletrocardiograma no primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina com associação eventual com azitromicina.

LIMPEZA

Após a transferência ou alta do paciente que estava em ISOLAMENTO, deve-se aguardar 2 horas se possível, até liberar o quarto para outro paciente. Durante este período, a higiene do quarto pode ser realizada e o profissional da higiene deve utilizar máscara do tipo respirador - N95.

A limpeza deverá ser realizada com os saneantes que são fornecidos pela Santa Casa, as funcionárias da limpeza receberão orientações sobre o manejo da limpeza adequada, priorizando a importância de higienizar adequadamente todas as superfícies que estiveram em contato com o paciente.

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

De acordo com o que se sabe até o momento, o COVID-19 pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem ser enquadrados na categoria A1.

Dessa forma, os resíduos devem ser acondicionados em SACO BRANCO LEITOSO, que devem ser substituídos imediatamente após a utilização da sala. Os sacos devem ser contidos em recipiente de material lavável e resistente e os resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.

AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE

FUNCIONÁRIO SINTOMÁTICO

Em caso de funcionário da área da saúde com sintomas de síndrome gripal, seguir as seguintes orientações:

- Afastar-se do trabalho imediatamente.
- Teste para COVID-19 (swab): resultado pode demorar em torno de 6 a 14 dias. Durante este período permanecer em afastamento e isolamento domiciliar.
- Se realizado teste para COVID-19, com resultado negativo, retornar ao trabalho se assintomático há pelo menos 3 dias.
- Se realizado teste para COVID-19, com resultado positivo, manter afastamento por 14 dias do início dos sintomas.

- Pode ser realizado exame de RT-PCR por swab (até o 7º dia do início dos sintomas) ou teste rápido sorológico (após o 8º dia do início dos sintomas).

FUNCIONÁRIO ASSINTOMÁTICO CONTACTANTE

Em caso de funcionário da área da saúde que tiver contato não domiciliar (não residir no mesmo domicílio) com paciente suspeito ou confirmado para COVID-19, seguir as seguintes orientações:

- Observar rigorosamente sinais e sintomas de síndrome gripal (febre, mialgia, dor de garganta, tosse) pelos próximos 14 dias do contato com o suspeito.
- Intensificar medidas de higiene e profilaxia de contato e gotículas ao lidar com os pacientes e público em geral.
- Continuar em suas funções durante o período.
- Em caso de sintomas de síndrome gripal procurar atendimento médico e ser afastado imediatamente.

Em caso de funcionário da área da saúde contactante domiciliar (mora no mesmo domicílio) de caso suspeito ou confirmado, o funcionário deverá:

- Manter afastamento por 14 dias do início dos sintomas do caso suspeito, se exame do caso positivo para COVID-19.
- Retornar ao trabalho se assintomático, em caso de exame para COVID-19 negativo do contactante suspeito.

FUNCIONÁRIO EM GRUPO DE RISCO

- Idade igual ou superior a 60 anos.
- Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica).
- Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC).
- Imunodepressão.
- Doenças renais crônicas em estágio avançado (III, IV e V).
- Diabetes mellitus, conforme juízo clínico.
- Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica.
- Gestação de alto risco.

Nestes casos, recomenda-se o afastamento laboral. Em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais, estes não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome gripal. Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte, assistência nas áreas onde NÃO são

atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal.

PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS

Ficam suspensos procedimentos (principalmente colonoscopias e endoscopias) e cirurgias de caráter eletivo, por período indeterminado, enquanto a situação epidemiológica da região estiver crítica.

Em casos de procedimentos de urgência, deverá ser feita justificativa pelo médico que indicou o procedimento e deverão ser tomadas todas as medidas de proteção preconizadas: uso de EPIs por todos os funcionários conforme protocolo acima (em centro cirúrgico e procedimentos utilizar máscara tipo PFF2/N95 devido risco de aerossolização, não usar máscaras com válvula em centro cirúrgico). A sala cirúrgica deverá passar por limpeza terminal após o término da cirurgia e aguardar 3 horas para nova utilização. Somente deverão ficar na sala a equipe necessária, evitando circulação de pessoas na sala.

PLANO DE AÇÕES

Ações	Responsabilidade	Conduta
Controle de estoque de EPIs	Almoxarifado	Levantamento de estoque atual, cálculo de estoque mínimo e aquisição de novos EPIs conforme é atingido o estoque mínimo.
Distribuição de máscaras cirúrgicas no ambulatório e recepção	Enfermagem do ambulatório Recepção	Deixar máscaras disponíveis na recepção e nos consultórios, para rápido fornecimento aos pacientes que sejam identificados como suspeitos.
Atualização de novas informações sobre o coronavírus	SCIH	Monitorar diariamente a situação epidemiológica e pesquisas científicas envolvendo o coronavírus, divulgando todos os dados pertinentes à equipe.
Comunicação visual para pacientes e visitantes	SCIH	Orientar etiqueta da tosse, sintomas suspeitos, condutas em caso de suspeita, condutas quanto à visitação de pacientes internados, esclarecendo a população local sobre o novo coronavírus.

Fornecimento de insumos para diagnóstico	Laboratório	Garantir a disponibilidade de KITs para coleta de exames para diagnóstico de COVID 19
Armazenamento de amostras	Laboratório	Armazenar amostra por até 72h a temperaturas de 4 a 8ºC.
Manejo de leitos	Enfermeiro responsável pela supervisão	Gerir a ocupação dos leitos conforme disponibilidade. Caso necessário, auxiliar na transferência de pacientes para outros hospitais.
Registro de todos os comunicantes	Enfermagem dos setores	Manter registro de todos os profissionais que prestarem atendimento a cada caso suspeito, bem como visitantes que tiverem contato com o mesmo.
Notificação de casos suspeitos	Médico assistente + SCIH	Médico assistente comunica o SCIH.
Limpeza dos quartos	SHL	Após liberação do leito aguardar 3 horas da saída do paciente e proceder a limpeza terminal do quarto utilizando os EPI's recomendados.
Descarte de resíduos	SHL	Os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, caracterizados como resíduos infectantes o ASG que retirar os resíduos deve utilizar EPI's recomendados.

REFERÊNCIAS:

RESOLUÇÃO SS-28 – DIARIO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO. 19 MARÇO DE 2020.

INFORME Nº 9 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS. 20/03/2020.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 08 ABRIL. 2020 – 06/02/2020.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS – 2019-nCov. 2020

PROTOCOLO LABORATORIAL PARA A COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019 – nCoV). 2020.

CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CVE). Novo coronavírus. Medidas de prevenção e controle de infecção a serem adotadas na assistência à saúde. Divisão de infecção hospitalar/CVE. Grupo técnico médico hospitalar/SERSA/CVS. 2020.

ORIENTAÇÃO SOBRE USO DE MÁSCARAS FRENTE A COVID-19 – SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA.

PROTOCOLO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 – AMIB / AMB / ABRAMEDE.

NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS – 08/04/2020.

DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA COVID-19; CONSENSO SBI, SBPT E AMIB – 18/05/2020.

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA MANUSEIO MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19; MS, 20/05/2020.

COMUNICADO DA SBPT SOBRE O USO DE DEXAMETASONA NO TRATAMENTO DA COVID-19.

ANEXO 1 – TERMO DE DECLARAÇÃO ISOLAMENTO DOMICILIAR

TERMO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº_____, residente e domiciliado na _____ Bairro _____, CEP _____ , na cidade de _____, Estado_____, declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____ sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início _____, previsão de término _____, local de cumprimento da medida _____ .

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar:

1._____

2._____

3._____

Assinatura da pessoa sintomática: _____

Data: _____/_____/_____ Hora: _____: _____

ANEXO 2 – DIVISÃO DE LEITOS PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID 19

Pediatria			
Quarto	**Leitos**		
101	**A**	**B**	**ISOLAMENTO 1 S/N**
102	**A**	**B**	**ISOLAMENTO 2 S/N**
103	**A**	**B**	
TEMOS 6 LEITOS NO TOTAL, DESTES 04 FICARAM RESERVADOS PARA ISOLAMENTO COVID 19			

Clínica Médica				
Quarto	**Leitos**			
201	**A**			
202	**A**			
203	**A**			
204	**A**			
205	**A**	**B**		
206	**A**	**B**		
207	**A**	**B**		
208	**A**	**B**		
209	**A**	**B**		
210	**A**	**ISOLAMENTO 2 COVID 19**		
211	**A**	**ISOLAMENTO 1 COVID 19**		
212	**A**	**B**	**C**	**D**
213	**A**	**B**	**C**	**D**
214	**A**	**B**	**C**	**D**
TEMOS 28 LEITOS NO TOTAL, DESTES 02 FICARAM RESERVADOS PARA ISOLAMENTO COVID 19				

Maternidade				
Quarto	**Leitos**			
301	**A**	**B**		
302	**A**	**B**		
303	**A**	**B**		
304	**A**	**B**	**C**	**D**
305	**A**	**B**	**C**	**D**
307	**A**			
308	**A**			
TOTAL: 16 LEITOS				

ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE CLOROQUINA

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

Hidroxicloroquina/Cloroquina em associação com Azitromicina para COVID 19

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), de que as avaliações médicas ou laboratoriais revelaram possibilidade ou comprovação de diagnóstico: COVID 19 causada pelo coronavírus SARS-COV-2, e com base neste diagnóstico me foi orientado o seguinte tratamento/procedimento: Cloroquina ou Hidroxicloroquina em associação com Azitromicina.

OS PROCEDIMENTOS, SEUS BENEFÍCIOS, RISCOS E ALTERNATIVAS

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), que:

1. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos disponíveis há muitos anos para a prevenção e tratamento da malária e também para o tratamento de algumas doenças reumáticas como artrite reumatoide e lúpus. Investigadores chineses demostraram a capacidade dessas drogas de inibir a replicação do coronavírus em laboratório (in vitro). Um estudo francês mostrou que a eliminação do coronavírus da garganta de portadores da COVID-19 se deu de forma mais rápida com a utilização da combinação de hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, quando comparados a pacientes que não usaram as drogas.

Entretanto, não há, até o momento, estudos suficientes para garantir certeza de melhora clínica dos pacientes com COVID-19 quando tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina;

2. A Cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias, e alterações visuais por danos na retina.

Compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos para a COVID-19 e que o medicamento proposto pode inclusive apresentar efeitos colaterais;

Estou ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associada à

azitromicina pode causar os efeitos colaterais descritos acima e outros menos graves ou menos frequentes, os quais podem levar à disfunção de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito.

Também fui informado(a) que, independente do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azitromicina, será mantido o tratamento padrão e comprovadamente benéfico para minha situação, que pode incluir medidas de suporte da respiração e oxigenação, ventilação mecânica, drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes.

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto no presente termo;

Esta autorização é dada ao(à) médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s);

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura;

Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, reservo-me o direito de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).

Pitangueiras, ____ de _____ de 2020. _____:_____(hh:min).

( ) paciente ( ) responsável

Nome: _____

Assinatura: _____

DECLARAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s)/procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Pitangueiras, _____ de _____ de 2020. _____:_____(hh:min).

Nome do médico:

_____

Assinatura e carimbo:

_____

Plano de Contingência UNIMED e SERMED Pitangueiras Corona Vírus

Objetivo
Tem como planejamento preventivo da organização para atuar durante um evento que acabe afetando as atividades normais da organização, com o intuito de treinar a equipe no enfrentamento de um possível surto de coronavírus.

Planejamento
O planejamento de contingência refere-se ao ato de estudar antecipado o cenário de uma organização com o objetivo de identificar riscos futuros que possam vir a acontecer.

Situação Atual
O coronavírus foi identificado primeiro na China no dia 07 de janeiro de 2020, somente em 30 de janeiro de 2020 que foi declarado que o surto do novo Coronavírus era de caráter emergencial da saúde pública e de importância internacional. Somente em 03 de fevereiro que o Brasil declarou Emergência de saúde publica de importância nacional, e em 11 de março de 2020 a OMS classificou a doença como Pandemia.

Transmissão
Acredita se que a transmissão venha acontecendo de pessoa para pessoa, sendo transmitida através de gotículas respiratórias produzidas na tosse ou espirros, sendo transmitida também por aerossóis em pacientes submetidos em procedimentos como intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas.

Sintomas
O Coronavírus (COVID-19) se caracteriza por sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar.
Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos e pessoas com outras condições médicas (como asma, diabetes e doença cardíaca) são mais vulneráveis a quadros graves.
Possíveis sintomas:
Dor de garganta
Tosse
Febre
Dificuldade para respirar (em casos graves)

Recepção
Ao chegar na recepção da Unimed, a recepcionista deverá perguntar ao mesmo paciente se esta apresentando sinais gripais como: FEBRE, TOSSE, DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, se o mesmo estiver qualquer um dos sintomas acima será entregue uma mascara e ele será direcionado para uma sala de espera separado dos demais pacientes, o médico será comunicado e fará o atendimento em um consultório reservado somente para casos como este. Após avaliação do mesmo o médico irá orientar a enfermeira as medidas a serem tomadas.

Sintomas Leves:
Se o paciente estiver apresentando sintomas leves, o mesmo será medicado em um local separado e orientado pela enfermeira quanto ao isolamento domiciliar e orientado caso apresente piora em seu quadro deverá procurar novamente atendimento médico.

Orientação em caso de isolamento domiciliar
Lavar frequentemente as mãos;
Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e sempre higienizar as mãos;
Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca;
Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, garrafas e toalhas;
Manter os ambientes bem arejados.

Casos moderados

Será solicitado pelo médico RX de tórax e Hemograma completo. Após Doutor irá avaliar os resultados para saber se encaixa em um caso grave ou se ficará em isolamento domiciliar.

Casos Graves

Após a avaliação médica desse paciente, o médico constatar que se trata de um caso grave, o mesmo será encaminhado para a Santa Casa de Pitangueiras onde será encaminhado para a sala de isolamento, acompanhado do médico responsável mais enfermagem, os profissionais que estiverem nessa sala deveram estar com os seguintes EPIs: Mascara N95, Protetor facial, Luvas de procedimento, Touca descartável, Avental descartável, caso seja solicitado coleta de exames o enfermeiro que estiver na sala devera fazer a coleta desses exames, pois já estará devidamente paramentado.
Foi estabelecido com o responsável do Laboratório Dr. Pacca os exames que deveram ser coletados para casos suspeitos de Cronavírus: Hemograma, PCR Quantitativo,TGO, TGP, ALBUMINA, LDH (Desidrogenase láctica), VHS, Bilirrubina, Creatinina e RX TORAX.

Na sala de urgência(isolamento) já estará um kit para coleta desses exames.
Quando esse profissional sair da sala de urgência deverá ser retirado todos os EPIs adequadamente evitando tocar nas superfícies, realizar higiene adequada das mãos com água e sabão.
Lembrando que esses pacientes serão encaminhados para a Santa Casa de Pitangueiras provisoriamente até a transferência ser consolidada para os seguintes lugares:

Convênio SERMED

O médico deverá encaminhar o mesmo para a Santa Casa de Sertãozinho, entrando em contato com o médico dessa unidade e passando o caso, logo em seguida o enfermeiro contatará o transporte da Sermed para que venha realizar a remoção desse paciente.

Convênio UNIMED

O paciente será encaminhado para um serviço de referência na cidade de Ribeirão Preto (HURP) Hospital Unimed de Ribeirão Preto, o médico entrará em contato com o médico receptor passando o caso para o mesmo e logo em seguida o enfermeiro deverá providenciar o transporte desse paciente para o encaminhamento para a instituição receptora.
O Swab será feito nas unidades receptoras que estarão recebendo esse paciente para internação.
Quando se tratar de algum profissional da saúde e que estiver apresentando quadro moderado dos sintomas não precisara estar internado para ser coletado o swab, assim poderá ser feito pelo enfermeiro da instituição e logo após encaminhar esse paciente para o isolamento domiciliar.

Recomendações para profissionais da saúde:

Higienização das mãos, sempre, antes e após qualquer contato com o paciente;

Mascara cirúrgica e a N95 somente em caso de coleta de swab do paciente ou em casos de intubação;
Luvas: trocadas sempre que for trocar de paciente;
Avental descartável: sempre que for ter contato com o paciente;
Óculos de proteção: realizar desinfecção com álcool 70% após cada uso;

Recomendações para funcionários da recepção:

Mascara Cirúrgica: usar a todo o momento, trocá-la a cada 02 horas;
Lavar sempre as mãos, sempre estarem lavando as mãos com água e sabão, e quando não conseguindo a todo o momento higienizar com álcool 70%.

Plano Operativo: Pronto Atendimento do São Francisco/ Hapvida do Hospital São Marcos de Jaboticabal.

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Estabelecer as diretrizes técnicas para atendimento de casos suspeitos no Pronto Atendimento do São Francisco/Hapvida do Hospital São Marcos de Jaboticabal.

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS

COVID 19 – Coronavírus
SCIH – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
ASG – Auxiliar de Serviços Gerais (Higiene e limpeza)

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Fluxo institucional - Atendimento aos casos suspeitos de infecção do Novo Coronavirus (COVID 19);

Cartão de acompanhamento

Orientação de acompanhantes em Emergência/PA

POP coleta de exame

POP limpeza concorrente

POP limpeza terminal

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Máscara cirúrgica
Mascara N95
Face sheild
Álcool gel
Álcool 70%
Gorro
Avental impermeável
Luva
Dispenser Sabonete liquido
Dispenser Clorexidina liquida
Papel toalha
Dispenser de Álcool
Óculos

5. PROCEDIMENTOS / ATIVIDADES DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Chegada do Paciente na Emergência

2. Pré Classificação e Priorização do Caso

   O porteiro estará com máscara cirúrgica e face sheild e questionará sintomas respiratórios (tosse ou espirro)

   Caso com resposta negativa

   - porteiro encaminha para recepção e segue fluxo norma de atendimento

   Caso com resposta afirmativa

   - porteiro fornece máscara, paciente será encaminhado para fluxo diferenciado de atendimento

   Na priorização

   - Paciente será atendido prioritariamente, visando reduzir o tempo de permanência na unidade

3. Disponibilização de máscara cirúrgica simples para pacientes sintomáticos e acompanhantes

   - Para casos já identificados na entrada será entregue pelo porteiro, não identificados nesse momento devem ser oferecidos na recepção ou pelo medico

   Só será permitido 1 acompanhante para paciente que tenha direito por lei, acompanhante que não esteja nesses critérios não poderá entrar na unidade.

4. Local para atendimento médico

   Os casos suspeitos serão atendidos nos consultórios e serão encaminhados para sala de estabilização e leitos específicos da observação, a depender da gravidade dos casos.

5. Montagem dos kits nas emergências para atendimento de casos suspeitos

   Médicos que atenderão na observação devem ficar paramentados e a troca deve ser realizada entre um atendimento e outro, além disso medico deve usar roupa privativa;

   A enfermagem fica responsável por checar a disponibilização dos kits e solicitar reposição a farmácia;

   Na sala de estabilização terá disponível kit com máscara N95;

6. Coleta da amostra, acondicionamento e transporte conforme POP e orientações vigentes.

7. As notificações serão realizadas na totalidade pela equipe de enfermagem;

8. Manejo de atendimento de casos com alta para isolamento domiciliar

   Oferecer cartilha;

Oferecer atestado de 14 dias (ou enquanto permanecerem sintomáticos) para pacientes com síndrome gripal;

Coleta de swab (nasal/oro) para todo paciente com síndrome respiratória aguda grave e para todo profissional da saúde com síndrome gripal;

9. Como e onde será a unidade destinada para internação hospitalar: quais os critérios de elegibilidade para internação em UTI e Unidade de Internação

   Encaminhar pacientes através da central de regulação do São Francisco/HAPVIDA

10. Escala de sobreaviso: plano B para ausência não previstas, aumento da demanda etc.

    Escala está sendo feita pela responsável de enfermagem

    Levantar médicos com disponibilidade para realizar plantões extras.

11. Limpeza concorrente e terminal da unidade / consultórios

    A limpeza concorrente e terminal continua seguindo protocolo padrão

    Para os consultórios o próprio médico fará a limpeza das superfícies após cada atendimento com álcool 70%

Orientações Gerais:

- Treinamentos com equipes administrativas, assistenciais e médica

- Realizado material de marketing como folder e banner de orientação, carteirinha de acompanhamento;

- Implementado regras de acompanhante;

- Suspensão de consultas eletivas, mantendo apenas as prioridades

6. CUIDADOS

- Pacientes graves com doença respiratória e indicação de terapia intensiva não devem permanecer na sala de estabilização, sendo encaminhado o mais precoce possível para hospital de referência
- Quando possível as intubações orotraqueais deverão ser prioritariamente realizadas dentro da unidade respiratória

7. RISCOS

Exposição material biológico
Contaminação com fluídos e matéria orgânica
Síndrome do estresse psicológico das equipes
Aumento do absenteísmo
Falta de insumos
Dificuldade para fechamento de escala médica
Tempo para contratação de recepção e enfermagem

8. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES
Acionamento imediato do corporativo

9. ANEXOS
Cartão de acompanhamento com orientações;
Termo de declaração de isolamento

Faz bem para você

CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
NOMECOMPLETO:_____

DATA NASCIMENTO: INÍCIO DE SINTOMAS:

APRESENTE SEMPRE ESTE CARTÃO AO PASSAR EM ATENDIMENTO

DATA	HORA	TEMPERATURA

PROCURE A EMERGÊNCIA DO HOSPITAL IMEDIATAMENTE SE APRESENTAR QUALQUER SINAL DE ALARME

Termo de declaração de isolamento

ORIENTAÇÕES GERAIS

• Etiqueta respiratória: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; manter ambientes limpos e arejado.
•Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos).
•Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.
•Realizar a higiene das mãos com água e sabonete frequentemente e usar álcool gel se as mãos não estiverem visivelmente sujas.
•Higienize suas mãos frequentemente.
•Não compartilhar objetos de uso pessoal como escova de dente, copos, talheres e garrafas.
•Se recomendado pelo médico isolamento social este deverá acontecer por pelo menos 7 dias após o inicio dos sintomas ou, caso os sintomas persistam por mais tempo, até 24 horas após o término deste (manter etiqueta respiratória utilizando lenço descartável,

cobrir a tosse e espirro com o cotovelo, manter ambientes limpos e arejados).

- Evitar contato com outros familiares e visitantes.
- Sair do domicílio somente em situações de real necessidade; caso sair, utilizar máscara cirúrgica.

ISOLAMENTO SOCIAL (DOMICILIAR)

• Se recomendado pelo médico isolamento social, este deverá acontecer por pelo menos 7 dias após o inicio dos sintomas ou, caso os sintomas persistam por mais tempo, até 24 horas após o término deste.

• Utilizar etiqueta respiratória: Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; manter ambientes limpos e arejado.

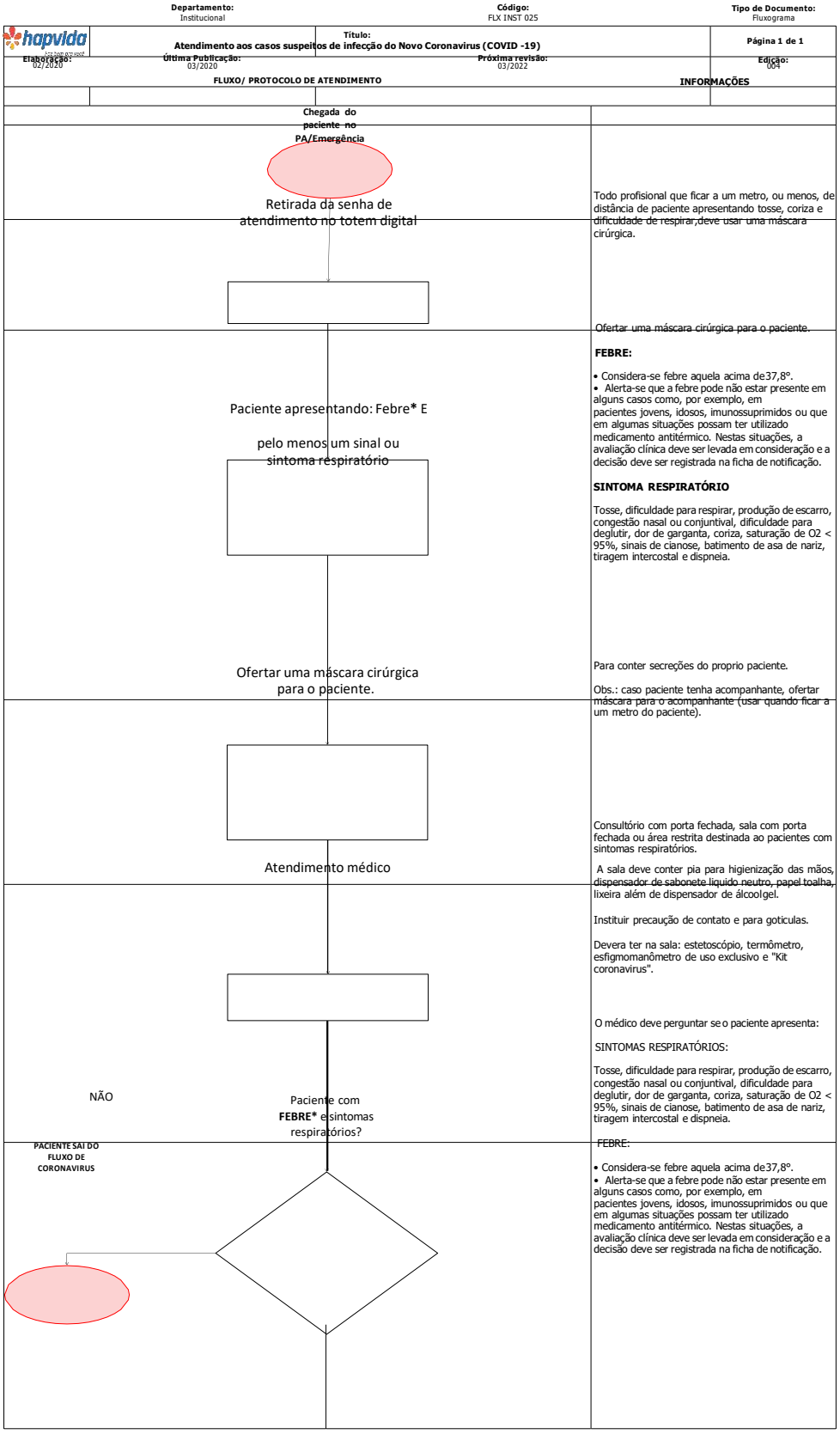
- Realizar a higiene das mãos com água e sabonete frequentemente e usar álcool gel se as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- Evitar contato com outros familiares e visitantes.
- Sair do domicílio somente em situações de real necessidade; caso sair, utilizar máscara cirúrgica.

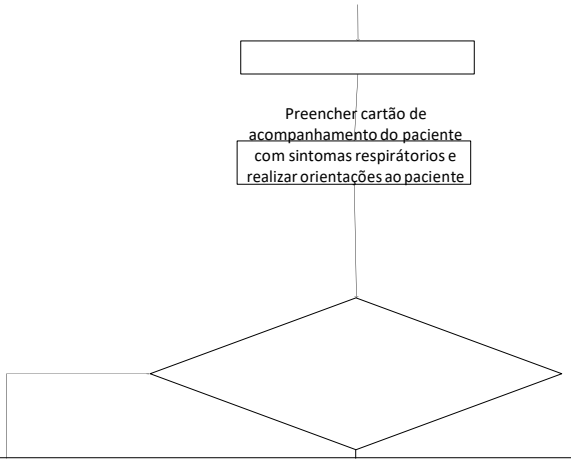
SINAIS DE ALARME

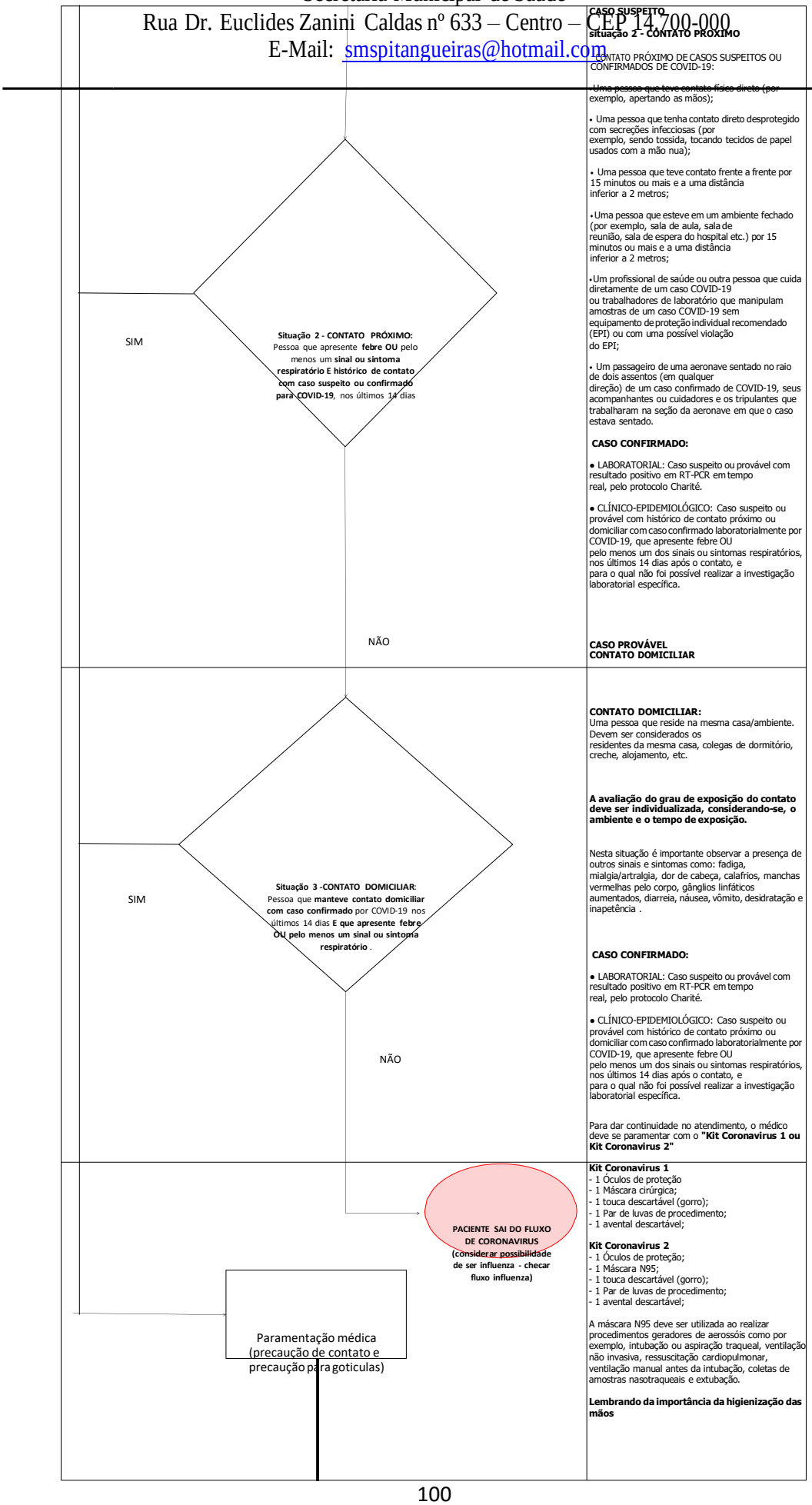
• Dificuldade para respirar;

- Batimento das asas nasais;
- Febre alta por mais de 48 horas;
- Vômitos frequentes;
- Dificuldade para ingesta de líquidos;
- Tonturas.

Fluxograma:


Departamento: Institucional
Código: FLX INST 025
Tipo de Documento: Fluxograma
Título: Atendimento aos casos suspeitos de infecção do Novo Coronavirus (COVID -19)
Página 1 de 1
Elaboração: 02/2020
Última Publicação: 03/2020
Próxima revisão: 03/2022
Edição: 004
FLUXO/ PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
INFORMAÇÕES
Chegada do paciente no PA/Emergência
Retirada da senha de atendimento no totem digital
Todo profisional que ficar a um metro, ou menos, de distância de paciente apresentando tosse, coriza e dificuldade de respirar,deve usar uma máscara cirúrgica.
Ofertar uma máscara cirúrgica para o paciente.
Paciente apresentando: Febre* E
pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
FEBRE:
• Considera-se febre aquela acima de37,8°.
• Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
SINTOMA RESPIRATÓRIO
Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.
Ofertar uma máscara cirúrgica para o paciente.
Para conter secreções do proprio paciente.
Obs.: caso paciente tenha acompanhante, ofertar máscara para o acompanhante (usar quando ficar a um metro do paciente).
Atendimento médico
Consultório com porta fechada, sala com porta fechada ou área restrita destinada ao pacientes com sintomas respiratórios.
A sala deve conter pia para higienização das mãos, dispensador de sabonete liquido neutro, papel toalha, lixeira além de dispensador de álcool gel.
Instituir precaução de contato e para goticulas.
Devera ter na sala: estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro de uso exclusivo e "Kit coronavirus".
O médico deve perguntar se o paciente apresenta:
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS:
Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.
FEBRE:
• Considera-se febre aquela acima de37,8°.
• Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
NÃO
Paciente com FEBRE* e sintomas respiratórios?
PACIENTE SAI DO FLUXO DE CORONAVIRUS

SIM Uso de máscara Cirúrgica (paciente e médico)	Caso o paciente ainda não esteja usando máscara cirúrgica, ofertar máscara cirúrgica imediatamente. O médico deve colocar máscara cirúrgica em si próprio para continuar o atendimento. O médico deve preencher o cartão de acompanhamento do paciente com sintomas respiratórios e entregar para o paciente.
	Orientar sobre etiqueta respiratória: • Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; • Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; • Realizar a higiene das mãos . Orientar sobre necessidade de retorno ao médico somente se paciente apresentar sinais de alarme: • Dificuldade para respirar; • Batimento das asas nasais; • Febre alta por mais de 48 horas; • Vômitos frequentes; • Dificuldade para ingesta de líquidos; • Tonturas.



CASO SUSPEITO
situação 2 - CONTATO PRÓXIMO

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:

- Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
- Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua);
- Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
- Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
- Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso COVID-19 sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI) ou com uma possível violação do EPI;
- Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado.

CASO CONFIRMADO:

- LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.
- CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

CASO PROVÁVEL
CONTATO DOMICILIAR

CONTATO DOMICILIAR:
Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se, o ambiente e o tempo de exposição.

Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência .

CASO CONFIRMADO:

- LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.
- CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

Para dar continuidade no atendimento, o médico deve se paramentar com o **"Kit Coronavirus 1 ou Kit Coronavirus 2"**

Kit Coronavirus 1
- 1 Óculos de proteção
- 1 Máscara cirúrgica;
- 1 touca descartável (gorro);
- 1 Par de luvas de procedimento;
- 1 avental descartável;

Kit Coronavirus 2
- 1 Óculos de proteção;
- 1 Máscara N95;
- 1 touca descartável (gorro);
- 1 Par de luvas de procedimento;
- 1 avental descartável;

A máscara N95 deve ser utilizada ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais e extubação.

Lembrando da importância da higienização das mãos

Manter o paciente em sala/consultório com porta fechada	Instituir precaução de contato e para goticulas. Após o atendimento médico, deve-se realizar limpeza concorrente no consultório antes de ser utilizado novamente.
Colocar pulseira preta no paciente	A pulseira preta é uma identificação visual de que o paciente está no fluxo de COVID-19.
O médico após avaliar o paciente deverá classificar os casos e acionar a coordenação médica.	Classificação dos casos: • Doença não complicada (IVAS) • Pneumonia s/ complicação • Pneumonia grave • SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda) • Sepse • Choque séptico
Discutir necessidade de exame laboratorial com coordenação.	Discutir com coordenação médica e o SCIH.
Exame laboratoria - Swab Rayon (Pesquisa coronavirus)	Em caso de exame laboratorial (Swab Rayon/Bronquinho - Pesquisa Coronavirus) **COLETA DEVE SER FEITA PELO ENFERMEIRO (A)** Se paciente for internar, a coleta deve acontecer no quarto de internação. Em caso de coleta em PA/Emergência, devera ser coletado em uma sala designada de porta fechada e realizada limpeza concorrente logo após a coleta. A **HIGIENIZAR AS MÃOS E USAR EPI:** **Kit Coronavirus 2** - 1 Óculos de proteção; - 1 Máscara N95; - 1 touca descartável (gorro); - 1 Par de luvas de procedimento; - 1 avental descartável; Coleta: • 3 Swabs: (1) narina direita, (1) narina esquerda e (1) orofaríngeo. Colocar os 3 swabs em um tubo falcon com 3 ml de soro fisiológico 0,9%. Caso grave (internado - intubado) : • Aspirado de nasofaringe (bronquinho). A coleta dos swabs combinados ou aspirado nasofaringeo (bronquinho) é em até 7 dias do início dos sintomas. Acondiconamento: amostras mantida em geladeira/câmera fria (4 a 8ºC +) do laboratório do hospital. Transporte para laboratorio do Hospital: Caixa térmica rigida. encaminhar imediatamente após a coleta Transporte do laboratório do Hospital para o Laboratório de apoio: Caixa térmica rigida, com gelox ou gelo (4 a 8ºC +) encaminhar em até 72 horas. É necessário cadastramento no GAL para encaminhamento da amostra ao Adolfo Lutz/laboratório de apoio de referência.
Definir local e estratégia de tratamento (A,B ou C)	Discutir com coordenação médica sobre internação.

TRATAMENTO

Tratamento Ambulatorial	**Internação Hospitalar - Enfermaria**	**Internação Hospitalar - CTI**
Doença não complicada	Saturação O2 < 92 %; e/ou FR> 30/min; e/ou Pneumonia e/ou Descompensação de doença de base	SARA, Sepse e Choque séptico (Considerar pneumonia grave)

- Isolamento social por pelo menos 7 dias ou até que fique assintomático (fornecer atestado médico).
- Iniciar medicamento para controle de sintomas e o Oseltamivir (dispensação nas UPAs e UBDS)
- Recomendações de prevenção: Higiene das mãos frequente, cobrir boca ounariz ao espirar, tossir / desinfetar objetos ; ambiente limpo e arejado ; evitar contato com pessoas doentes.

- Isolamento o mais rápido possível, com precaução padrão, de contato e para gotículas **até que o paciente esteje assintomático**
- Quarto privativo.
- Controle dos sintomas, início o mais precoce de Oseltamivir até o 5º dia dos sintomas , considerando influenza/H1N1.
- Oxigenioterapia para SpO2 > 90%; gestantes manter SpO2 > entre 92-95%.
- Antibioticoterapia empírica considerando pneumonia de comunidade.
- Hidratação venosa com cristalóides (cuidado com a congestão pulmonar).
- Compensação da doença de base.
- Monitorização de sinais que indique deterioração clínica e transferência para CTI.

- Isolamento o mais rápido possível, com precaução padrão, de contato e para gotículas, N95 se procedimento gerador de aerosois, até que o paciente esteje assintomático
- Inicio o mais precoce de Oseltamivir até o 5º dia do início dos sintomas, considerando influenza/H1N1.
- Antibiótico empírico considerando pneumonia de comunidade.
- Cuidados intensivos , suporte ventilatório e seguir protocolos da CTI.

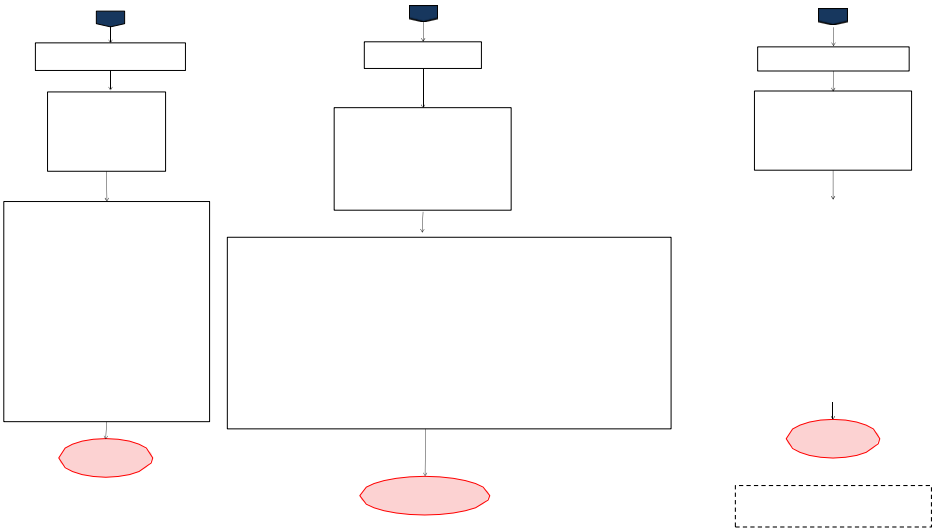
Internação de CTI

Alta

Internação de Enfermaria

Oseltamivir:
- Atentar posologia conforme o peso, e ajuste para disfunção renal

A primeira etapa da notificação é ligar imediatamente ou em até 24 horas para a vigilância epidemiológica
Vigilância Epidemiológica Ribeirão Preto:
(16) 3977-9355/9357/9334
(16) 99762-8004



RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE E DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS **Fonte: GVIMS/GGTES/Avisa, Janeiro de 2020**	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E ACOMPANHANTES	Usar máscara cirúrgica. Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal). Higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica; óculos de proteção ou protetor facial; máscara cirúrgica; avental descartável, de uso único, luvas de procedimento e gorro, durante atendimento ao paciente. Descartar os EPI's após realizar o atendimento. Observação: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais e extubação. **Atenção: não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento. Higienizar as mãos antes de calçar EPI e após retirar EPI.**
PROFISSIONAIS DE APOIO, CASO PARTICIPEM DA ASSISTÊNCIA DIRETA AO CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO	**Utilizar EPI's (kit coronavirus) e higienizar as mãos.** EPI's: Óculos de proteção ou protetor facial Máscara cirúrgica Avental descartável Luvas de procedimento Gorro
Limpeza e desinfecção de superfícies	Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo COVID-19. Utilizar varredura úmida. Realizar limpeza concorrente em consultórios e salas de exames após atendimento médico. Realizar Limpeza terminal em quarto de internação após alta/óbito/tranferência do paciente e em sala cirúrgica. O desinfectante padronizaco é o Oxivir, mas pode ser utilizado outro desinfetante como hipoclorito de sódio 1% ou álcool 70%. **Utilizar EPI's (kit coronavirus) e higienizar as mãos.** Limpeza concorrente - higienzar as mãos e usar EPI Kit Coronavirus 1 (máscara comum) Limpeza terminal - higienzar as mãos e usar EPI Kit Coronavirus 2 (máscara N95). Manter a porta do quarto fechada por 2 horas e sem uso após limpeza terminal para dissipar as particulas de aerossóis geradas.
Limpeza e desinfecção equipamentos	Após cada término da jornada de trabalho, todos os equipamentos da assistência deverão ser limpos ainda com os profissionais usando EPI, com lenços de OXIVIR, pela equipe da enfermagem. **Higienizar as mãos.**
Limpeza e desinfecção unidade de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência	Recomendamos a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o processo de higienização Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio , Oxivir ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos. Além das superfícies fixas da ambulância, todos os equipamentos médicos deverão ser higienizados e desinfetados. **Utilizar EPI's e higienizar as mãos.**
Descarte de Resíduos (incluindo os EPI's)	Resíduo infectante
Visita e acompanhantes	Restritas e orientadas Os acompanhantes devem ser orientados a permanecer sempre junto ao paciente sem circular pelos outros leitos. Acompanhantes e visitantes deverão ser orientados quanto à **higienização das mãos** e contato exclusivo com o visitado. Não há necessidade de avental, luvas, gorro e máscara N95 para visitantes e familiares, **somente o uso de máscara cirúrgica se ficar em contato com o paciente em um metro ou menos de distância. Trocar a máscara cirúrgica sempre que úmida.**
Transporte do paciente	O transporte do paciente deve se ro mínimo possível. Deve ser ofertado máscara cirurgica ao paciente (para conter secreções) quando estiver fora do quarto/leito de isolamento.

REFERÊNCIAS

1. Boletim Epidemiológico – COE COVID-19 – 04/03/2020

2. Protocolo Municpial para enfrentamento ao Novo Coronavírus (2019-nCoV). Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto - SMS, Departamento de Vigilância em Saude, Divisão de Vigilância Epidemiológica - Rib. Preto, 26 de fevereiro de 2020

3. Protocolo de Manejo clínico para o novo coronavirus (2019-nCoV). Ministério da Saúde , 2020. 32p.

4. Novo coronavirus (2019ncov) medidas de prevenção e controle de infecção a serem adotadas na assistência à saúde 29 de janeiro de 2020 divisão de infecção hospitalar/cve grupo técnico médico hospitalar/sersa/cvs

5. nota técnica nº 04/2020 gvims/ggtes/anvisaorientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019- ncov). anvisa 30/01/2020

6. Protocolo de tratamento de Influenza: 2017. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 49 p. : il.

ASSISTENCIAL / OPERACIONAL: Dra. Silvia Fonseca, Dra. Franceliana Prado Barbosa Sgobi Dra. Christianne Takeda Leilane Gonçalves Letícia Calicchio Maria Luiza F. Augusto	**QUALIDADE**: Thiago Curcioli	**ADMINISTRATIVO**:
SITUAÇÃO DE REVISÃO		**Data: 04/03/2020**
Título: Atendimento aos casos suspeitos de infecção do Novo Coronavirus (COVID -19)		**Código: FLX INST 025**
Alterado por: Maria Luiza Freitas Augusto		**Número da Edição: 004**
Descrição da Modificação: Atualizado sobre critério diagnostico (situação 1 -viajante: Histório de viagem para Ásia e/ou América do norte e/ou Europa).		